FAMILY CARE FIRST | REACT

www.fcf-react.org

មេរៀនជាបទពិសោធន៍ដែលទទួលបាន ពីការបង្ការ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ

សហភាពអឺរ៉ុប

USAID ជំនួយពីពលរដ្ឋអាមេរិក

GHR FOUNDATION

Save the Children 100 YEARS

unicef

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការយូនីសេហ្វ ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ក៏ដូចជាដល់អង្គការទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការតបសម្ភាសន៍ ដូចជា៖ អង្គការ Cambodia Children's Trust អង្គការ Children's Futures International អង្គការ Friends International អង្គការ Hagar International អង្គការ Holt អង្គការកុមារីកាយ អង្គការមិត្តសម្លាញ់ អង្គការម្លប់ឫស្សី អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា (This Life Cambodia) និងអង្គការយូនីសេហ្វ ដែលបានផ្តល់ជាបទពិសោធន៍ និងដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។ យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Better Care Network ដែលបានផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផងដែរ។

Rebecca Smith

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

សេចក្តីបញ្ជាក់

ការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ អាចធ្វើទៅបានដោយសារមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏សប្បុរសពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID)។ ខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារទាំងនេះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមទីប្រឹក្សា និងអង្គការ Save the Children និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬ (USAID) នោះឡើយ។

មាតិកា

មេរៀនជាបទពិសោធន៍ដែលទទួលបាន ពីការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ 1

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 2

សេចក្តីបញ្ជាក់ 3

មាតិកា 4

ពាក្យកាត់ និងអក្សរកាត់ 5

សេចក្តីសង្ខេប 6

សាវតារ 9

គោលបំណងនៃការសិក្សា 12

វិធីសាស្ត្រ 13

- សំណួរស្រាវជ្រាវ 13
  - ការពិចារណាផ្នែកក្រមសីលធម៌ 15
  - ដែនកំណត់ក្នុងការសិក្សា 16

លទ្ធផលរកឃើញ 17

- ភាពជាដៃគូ និងការសម្របសម្រួល 18
- ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងការបង្កើតចក្ខុវិស័យរួម 21
- ការគាំទ្ររបស់សហគមន៍ 26
- តួនាទីរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ 27
- ការពិចារណាអំពីបុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ 30
- គម្រោងពេលវេលាជាក់លាក់ 31
- ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាបន្ទាន់ 32

អនុសាសន៍ 34

ឧបសម្ព័ន្ធ 37

- ឧបសម្ព័ន្ធទី I៖ សំណួរសម្រាប់សម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ 37

ពាក្យកាត់ និងអក្សរកាត់

CCWC	Commune Committee for Women and Children	គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ ឃុំ/សង្កាត់ (គ.ក.ន.ក)
DoSVY	Department of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation	មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
FCF	Family Care First	គម្រោងថែទាំកុមារក្នុងគ្រួសារជាអទិភាពចម្បង
KII	Key Informant Interview	ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
MoI	Ministry of Interior	ក្រសួងមហាផ្ទៃ
MoSVY	Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation	ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ)
MoU	Memorandum of Understanding	អនុស្សរណៈស្តីពីការយោគយល់
NGO	Non-Government Organisation	អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
NISA	National Institute for Social Affairs	វិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច
RCI	Residential Care Institution	មណ្ឌលថែទាំកុមារ
REACT	Responsive and Effective Child Welfare System Transformation	គម្រោងឆ្លើយតបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធសុខមាលភាពកុមារ
SBCC	Social Behaviour Change Communication	ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសង្គម តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង
SOP	Standard Operating Procedure	នីតិវិធីប្រតិបត្តិតាមស្តង់ដារ
UNICEF	United Nations Children's Fund	អង្គការយូនីសេហ្វ
USAID	United States Agency for International Development	ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ
WCCC	Women and Children Consultative Committees	គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ (គ.ក.ស.ក)
3PC	Partnership Program for the Protection of Children	កម្មវិធីភាពជាដៃគូដើម្បីកិច្ចការពារកុមារ

សេចក្តីសង្ខេប

"មណ្ឌលថែទាំកុមារ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាលមួយដែលមានសេវាប្រមូលផ្តុំសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារ ដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ចាំបាច់ គឺត្រូវធ្វើវិមជ្ឈការសេវាគាំទ្រទាំងនេះ ត្រឡប់ទៅកាន់សហគមន៍វិញ"
អ្នកតបសម្ភាសន៍ទី ៣

កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភ ជុំវិញកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៃចំនួនកុមារដែលស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជា[1] ដូច្នេះទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលដៅធ្វើសមាហរណកម្មកុមារចំនួន ៣០% ពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ (RCIs) ទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។[2] ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៩ មណ្ឌលថែទាំកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា មានការថយចុះ ៤៣% ហើយចំនួនកុមារដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងនេះក៏មានការថយចុះ ៥៩%។[3]

ទន្ទឹមនឹងការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពទាំងនេះ ជំងឺកូវីដ ១៩ បានបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាសកលសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារផងដែរ។ ខណៈពេលដែលជំងឺរាតត្បាតនេះ មានផលវិបាកដ៏អាក្រក់ជាច្រើន យើងឃើញថាវាក៏បានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផងដែរ ដូចជា៖ ឱកាសសម្រាប់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រើប្រាស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ ផលវិបាកនៃការបិទមណ្ឌលជាបន្ទាន់ សារសំខាន់នៃការពិនិត្យតាមដានលើការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ និងការពឹងផ្អែករបស់មណ្ឌលថែទាំកុមារលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិជាមធ្យោបាយក្នុងការរៀអង្គាសថវិកា។ ការបង្វែមណ្ឌលថែទាំកុមារ ទាមទារឱ្យមានសមាសភាគសំខាន់ៗជាច្រើន មានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលចាំបាច់ត្រូវយកមកធ្វើការពិចារណាក្នុងពេលតែមួយ ក្នុងនោះ មានដូចជា៖

- មូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យកុមារចូលស្នាក់នៅក្នុងតាមមណ្ឌលថែទាំកុមារ
- ច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលកំពុងមានជាធរមាន
- ការលើកទឹកចិត្ត និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀអង្គាសថវិកា របស់អ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងម្ចាស់ជំនួយ
- ភាពអាចរកបាននូវសេវាដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ រួមមាន សេវាថែទាំជំនួសតាមគ្រួសារ
- តម្រូវការរបស់កុមារម្នាក់ៗដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ
- សមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសមាហរណកម្ម។

---

1 *ការរៀបចំផែនទីបង្ហាញពីទីតាំងនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង ២៤ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។* រៀបចំដោយ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៧)

2 *ផែនការសកម្មភាព ដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែទាំកុមារ ជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅបញ្ជូនកុមារ ៣០% ត្រឡប់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់ពួកគេវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ២០១៦-២០១៨។* (បន្តអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២០) របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (២០១៧)។

3 *របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការថែទាំកុមារ។* របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (២០២០)។

អ្នកឆ្លើយតបចំពោះការសម្ភាស បានលើកឡើងពីប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារប្រកបដោយជោគជ័យ លើសពីនេះទៀតបានកំណត់ពីចំណុចចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតផងដែរ។

ចំណុចទាំងនេះរួមមាន៖

- *ក្របខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ជាតិរឹងមាំ៖* រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្របខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ជាតិមួយយ៉ាងរឹងមាំ តាមរយៈការកសាងផែនការសកម្មភាពជាតិ ដែលដាក់សម្ពាធលើមណ្ឌលថែទាំកុមារឱ្យធ្វើការបង្វែរ និងគាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារប្រកបដោយជោគជ័យ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី វាទាមទារឱ្យមានការងារជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើ ដើម្បីបន្តឱ្យការឆ្លើយតបផ្នែកលើកិច្ចការពារកុមារមានលក្ខណៈស្ថង់ដារនៅទូទាំងប្រទេស។ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ព្រមទាំងសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចការពារកុមារឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នឹងជួយគាំទ្រដល់ការធ្វើឱ្យមានជាស្ថង់ដារនេះ។ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការពង្រឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ ការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំ និងបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលទើបត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះនឹងអាចជួយបន្តគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគី រវាងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ) មណ្ឌលថែទាំកុមារ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ដែលវាបានជួយគូសបញ្ជាក់បន្ថែមពីចក្ខុវិស័យរួម និងផែនការក្នុងការសម្រេចបាននូវការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារ។

- *តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធ៖* ទាមទារចាំបាច់ឱ្យនូវមានការគូសបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្ត ជាពិសេសតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវនៅកម្រិតថ្នាក់ស្រុក ក្នុងការគាំទ្រការបង្វែរ មណ្ឌលថែទាំង និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ។ ការវិនិយោគបន្ថែម (ដូចជា ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ការគាំទ្របច្ចេកទេស និងធនធាន) ដល់មន្ទីរ ស.អ.យ ការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខមាលភាពសង្គមក្រុងស្រុកខណ្ឌ និង គ.ក.ន.ក និងបន្តជួយពង្រឹងអំណាចតួនាទីបន្ថែមដល់ពួកគេក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

- *ការគាំទ្រដល់ "វិធីសាស្ត្រ"៖* នាយក និងអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ចាំបាច់គួរបន្តទទួលបានការគាំទ្រនានា តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងការចែករំលែកឧបករណ៍ គោលនយោបាយ ព្រមទាំងនីតិវិធីនានា ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញពីវិធីសាស្ត្រនៃការបង្វែរដំណើរការទៅបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងបានរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចក្ខុវិស័យរួម។

- *ការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយ និងការកំណត់គោលដៅឱ្យបានច្បាស់ក្នុងការធ្វើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយ៖* ខណៈពេលដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារសំខាន់នៃការថែទាំកុមារក្នុងគ្រួសារ និងផលវិបាកនៃការថែទាំកុមារតាមមណ្ឌលថែទាំ នៅមានការងារជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀត ដើម្បីកំណត់ការផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍នៅតាមទី

ជនបទ និងម្ចាស់ជំនួយនានាដែលខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ បុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសារ និងសហគមន៍មានការលើទឹកចិត្តតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នា ក្នុងការបន្តគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារ។ គេចាំបាច់ត្រូវឈ្វេងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពី ការលើកទឹកចិត្ត និងការព្រួយបារម្ភ ទើបអាចងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយឱ្យកាន់តែជាក់លាក់ និងចំគោលដៅ។ នៅមានកត្តាជាច្រើនទៀត ដែលយើងអាចសិក្សា និងយកមកអនុវត្តបានតាមបច្ចេកទេសនៃ **យុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ**របស់ក្រុមគោលដៅបានជាក់លាក់។

- ***ការស្វែងរកការគាំទ្រមតិ និងការចូលរួមជាមួយម្ចាស់ជំនួយ៖*** ដោយហេតុថា ម្ចាស់ជំនួយអាចមានឥទ្ធិពលដល់ភាពជោគជ័យ ឬមិនជោគជ័យក្នុងការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ការបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់ជំនួយ ដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូឱ្យកាន់តែរឹងមាំ ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្វែងរកការគាំទ្រមតិនៅតាមប្រទេសផ្តល់ជំនួយ និងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធីនានុវត្តន៍ស្រដៀងគ្នា ដើម្បីបញ្ឈប់ការស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រា ឧទាហរណ៍ដូចជា យុទ្ធនាការទេសចរណ៍សុវត្ថិភាពកុមាររបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ជាដើម។ មេរៀនជាបទពិសោធន៍ជាច្រើនទៀត អាចឈ្វេងយល់បន្ថែមទៀតពីរបៀបដែលម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមារម្នាក់ៗ ទៅធ្វើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមារតាមបែបសហគមន៍ក្នុងបរិបទផ្សេងទៀត។

- ***សេវាតាមសហគមន៍៖*** ការបង្វែរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទាមទារឱ្យមានការឆ្លើយតបជាមុនសិនដោយមូលហេតុនានាដែលនាំឱ្យមានការយកកុមារទៅទុកជាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ យើងចាំបាច់ត្រូវមានការវិនិយោគឱ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅលើសេវាតាមសហគមន៍ និងការផ្តល់សេវាឱ្យបានដល់គ្រួសារដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ ១៩។

- ***គម្រោងពេលវេលាជាក់លាក់៖*** ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ អាចត្រូវការពេលវេលាច្រើន។ ការមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំផែនការបង្វែរ និងបង្កើតទស្សនវិស័យរួមមួយ ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិក អ្នកថែទាំកុមារ ហើយសំខាន់ជាងនេះទៀត គឺកុមារដែលស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាល ម្ចាស់ជំនួយ និងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ដែលកំពុងគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការបង្វែរ ចាំបាច់ត្រូវទុកពេលវេលាឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ រួមទាំងធនធានមនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការនេះ។

- ***ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាបន្ទាន់៖*** ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាបន្ទាន់ៗ អាចបង្ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារ និងបង្ការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ បើទោះជាការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារបន្ទាន់ គឺជារឿងចាំបាច់ក៏ដោយ យើងគួរតែធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំផែនការទៅតាមជំហានៗ ដរាបណាកន្លែងថែទាំមួយមិនបង្កហានិភ័យជាក់ស្តែងភ្លាមៗចំពោះកុមារ។ មន្ទីរ

ស.អ.យ គួរតែដើរតួនាទីឱ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ ក្នុងការសម្របសម្រួលដល់ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារបន្ទាន់ ដោយហេតុថា មិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមានអណត្តិនៅក្នុងដំណើរការនេះ។

សាវតារ

យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៧ ដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា "តាមទំលៀមទំលាប់ប្រពៃណី ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់យន្តការថែទាំមតាមសហគមន៍ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ។ ការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សនៃចំនួនកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថែ និងដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ក្នុងប្រទេសនេះ បានបង្កជាក្តីបារម្ភចំពោះរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកិច្ចការពារកុមារ។"[4] ចន្លោះពីឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ ២០១០ ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជា កើនឡើង ៧៥%។[5]

យោងបើតាមរបាយការណ៍ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារក្នុងឆ្នាំ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបង្ហាញថា មានកន្លែងថែទាំកុមារចំនួន ៦៣៩ ទីតាំង (៤០៦ ទីតាំងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាមណ្ឌលថែទាំកុមារ) ដែលមានកុមារអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំសរុបចំនួន ២៦.១៨៧ នាក់កំពុងស្នាក់នៅ និងមានកុមារចំនួន ១៦.៥៧៩ នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំង ៤០៦ កន្លែង។[6] នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា មណ្ឌលថែទាំកុមារមានចំនួនមិនស្មើគ្នាទេ ដោយមណ្ឌលថែទាកុមារភាគច្រើនមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលភ្ជៀវទេសចរឧស្សាហ៍ទៅកំសាន្ត និងស្ថិតក្រោមកម្មវិធីទេសចរណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត។ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ កាលពីឆ្នាំ ២០១៦ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ) បានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដែលកំពុងស្នាក់នៅតាមមណ្ឌលថែទាំកុមារ ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ៥ និងបានកំណត់ការផ្អាកចុះឈ្មោះមណ្ឌលថែទាំកុមារថ្មី។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបង្កើតក្របខណ្ឌគតិយុត្តក្នុងបរិយាកាសអំណោយផល តាមរយៈការដាក់ចេញជាគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងគោលដៅកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ។[7] ទាំងនេះបានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ឱ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន ក៏ដូចជា ដើម្បី*សម្របទៅតាម*

---

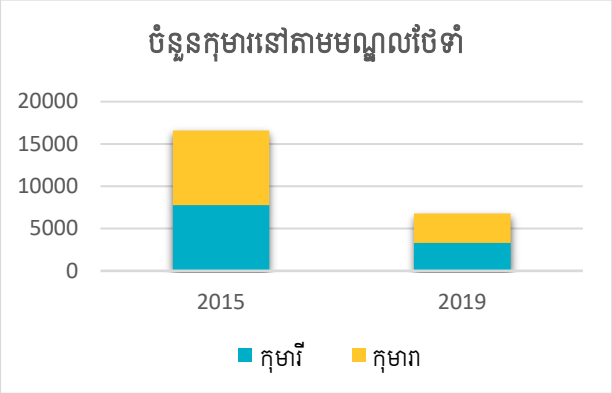
4 *[<u>របាយការណ៍កំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារនៅក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង ២៤ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។</u>]* រៀបចំដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៧)។

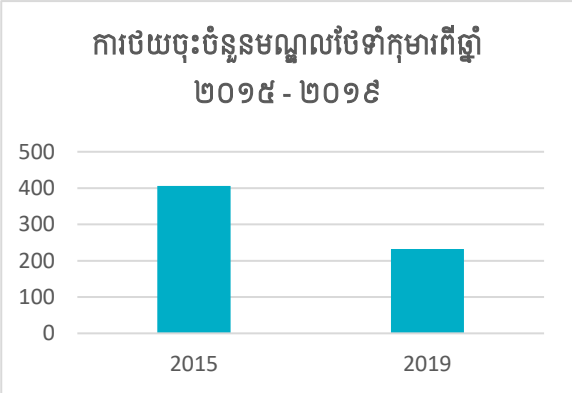
5 កម្រងព័ត៌មានស្តីពីវិស័យថែទាំកុមាររបស់កម្ពុជា រៀបចំដោយបណ្តាញ Better Care Network. (២០២០)។ និងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។

6 *[<u>របាយការណ៍កំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារនៅក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង ២៤ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។</u>]* រៀបចំដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៧)។

7 សម្រាប់បញ្ជីច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់នេះ សូមមើលទំព័រទី ២៦-៣៣ នៃកម្រងព័ត៌មានស្តីពីវិស័យថែទាំកុមាររបស់កម្ពុជា រៀបចំដោយបណ្តាញ Better Care Network. (២០២០)។ និងក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។

ផែនការសកម្មភាព និងអាទិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញជុំវិញកំណែទម្រង់ការថែទាំកុមារ។[8] ផែនការសកម្មភាពរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៨ បានពន្យាពេលដល់ឆ្នាំ ២០២០។[9] បើយោងតាមការពិនិត្យលើផែនការសកម្មភាពនេះនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារបានថយចុះ ៤៣% ហើយចំនួនកុមារដែលស្នាក់នៅក្នុងណ្ឌលទាំងនេះ បានថយចុះ ៥៩%។





កម្មវិធីថែទាំកុមារក្នុងគ្រួសារជាអាទិភាពចម្បង Family Care First (FCF) ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការ Save the Children ប្រចាំសង្គ្រោះកុមារ បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក្រោមជំនួយគាំទ្រថវិកាពីទីភ្នាក់ងារពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ក្នុងកិច្ចសហការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយចំនួនកុមារស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានផ្តល់ថវិកាបន្ថែមដល់គម្រោងឆ្លើយតបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធសុខមាលភាពកុមារ (REACT) ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឱ្យសិទ្ធិកុមារ និងការចូលរួមរបស់កុមារ នៅតែមានវត្តមានសំខាន់បន្តក្នុងការកែទម្រង់វិស័យថែទាំកុមារនេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ FCF | REACT គឺជាបណ្តាញដែលមានសមាជិកប្រមាណ ៦០ អង្គការ ដែលក្នុងនោះអង្គការមួយចំនួនបានទទួលថវិកាគាំទ្របន្ត ដើម្បីធ្វើការងារការពារកុមារពីការបំបែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ និងដើម្បីបង្កើនចំនួនកុមារដែលត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ទៅក្នុងការថែទាំតាមគ្រួសារប្រកបដោយជោគជ័យ។ សកម្មភាពនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើលទ្ធផលសំខាន់ៗចំនួន ៤ ដូចតទៅ៖

១. រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការអនុវត្តក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដាន។
២. អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង៥ បានទទួលការគាំទ្រ ក្នុងការពិនិត្យតាមដានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពនៃសេវាការពារ និងមណ្ឌលថែទាំកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

---

8 *ផែនការពង្រឹងការថែទាំកុមារ និងសមាហរណកម្មកុមារចំនួន ៣០% ពីមណ្ឌលថែទាំកុមារទៅកាន់គ្រួសារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ២០១៦-២០១៨។* (បន្តអនុវត្តដល់ឆ្នាំ ២០២០) ដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (២០១៧)។

9 Ibid

៣. កុមារី និងកុមារ ដែលមិនបានទទួលការថែទាំពីឪពុកម្តាយ និង/ឬបំបែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ បានទទួលការថែទាំជំនួសសមស្របប្រកបដោយគុណភាព និង/ឬការធ្វើសមាហរណកម្ម។
៤. វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង ៥។

តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ស្របតាមឧបករណ៍តាមដានកុមារ កុមារ ៤១% នៅក្នុងខេត្តគោលដៅដែលត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្ម បានទទួលការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាល ឬពីដៃគូនៃកម្មវិធី 3PC និង គម្រោង FCF | REACT។[10]

[10] *របាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការពង្រឹងការថែទាំកុមារ* របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (២០២០)។

គោលបំណងនៃការសិក្សា

ការសិក្សានេះ មានគោលបំណងចង់ក្រងមេរៀនជាបទពិសោធន៍របស់សមាជិក FCF | REACT ក៏ដូចជាពីឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការស្ថាប័ននានាដែលធ្វើការផ្តោតលើការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីផ្តល់ជាអនុសាសន៍ផ្អែកលើភស្តុតាងពីការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារនាពេលអនាគតខាងមុខ។ របកគំឃើតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ នឹងផ្តល់ជូនក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អង្គការយូនីសេហ្វ និងសមាជិកបណ្តាញ FCF | REACT ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិស័យនេះ ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់រៀបចំបញ្ចប់ឯកសារគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្ម ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។

វិធីសាស្ត្រ

ការកំណត់ និងការប្រមូលចងក្រងមេរៀនជាបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានក្នុងរបាយការណ៍នេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចម្បងចំនួន ២៖

- ការពិនិត្យលើឯកសារ/ការសិក្សាដែលមានស្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ ការពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធនេះ ផ្តោតអាទិភាពលើការងារដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកបណ្តាញ FCF | REACT និងការងារដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ចូលឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរ
- ការសម្ភាសន៍ (KII) ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដែលបានចូលរួម ឬផ្តល់គំនិតសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។

សំណួរស្រាវជ្រាវ

- តើការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្រោមលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះ?
    - តើការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្រោមលក្ខខណ្ឌណាខ្លះ (តើវាខុសគ្នា ឬស្រដៀងគ្នាអ្វីខ្លះនឹងការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារ?)
- តើមានជំហាន ដំណាក់កាល និងដំណើការសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ និងតើមានតួអង្គពាក់ព័ន្ធណាខ្លះ ដែលចូលរួមក្នុងការបង្វែរ និង ឬការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ?
- តើវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែលមានប្រយោជន៍ជាងគេ? ហេតុអ្វី?
- តើយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ និងតើយើងធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីអាចឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងនេះឱ្យបានល្អបំផុត?
- តើលក្ខខណ្ឌ និងវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះ ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នា (ឬដូចគ្នា) សម្រាប់ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ?
- តើចាំបាច់ត្រូវមានឧបករណ៍ និងការណែនាំបន្ថែមទៀតអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវមាន?
- សូមធ្វើការប្រៀបធៀបបទពិសោធន៍នៃការបង្វែរ/ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដទៃទៀត?

ការប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ

ការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ

ការប្រមូលឯកសារដែលមានស្រាប់ ដើម្បីយកមកពិនិត្យសម្រាប់ការសិក្សានេះ ធ្វើឡើងចំនួន ២ បែប៖

១. ឯកសារថ្នាក់ជាតិ ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានកំណត់ដោយក្រុមការងារនៃបណ្តាញ FCF | REACT ទៅតាមចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីឯកសារទាំងនេះ ក៏ដូចជាការស្នើសុំទៅសមាជិកបណ្តាញទាំងមូល ដើម្បីសុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលពួកគេបានដឹងបន្ថែមទៀត។
២. ឯកសារថ្នាក់សកល ជាពិសេសឯកសារពីបណ្តាញ Better Care Network និងកិច្ចសហការផ្តល់យោបល់ពីសមាជិកក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារថ្នាក់ជាសកល (Global Collaborative Platform Transitioning) ការស្វែងរកអត្ថបទ និងសម្រង់អត្ថបទដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ បណ្តាញចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពីកិច្ចការពារកុមារក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិ (CPC Learning Network) និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់អង្គការ **Save the Children**។ លើសពីនេះក៏មានការស្វែងរកក្នុង google ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យគន្លឹះ "transitioning residential care" ផងដែរ ដើម្បីធានាថាពុំមានចំណុចណាមួយត្រូវបានទុកចោលនោះឡើយ។

ឯកសារសម្រាប់ការវាយតម្លៃនេះ ត្រូវបានជ្រើសរើសដាក់បញ្ចូលទៅតាមភាពពាក់ព័ន្ធរបស់វាទៅនឹងប្រធានបទ (ឧទាហរណ៍ ឯកសារផ្តោតលើការបង្វែរ/ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាដើម) ជាជាងឯកសារដែលផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំកុមារតាមមណ្ឌល។ ការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធធ្វើឡើង សម្រាប់ឯកសារជាភាសាអង់គ្លេស ដោយមានការពិនិត្យតែលើឯកសារដែលពុំត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ (grey literature) ឬឯកសារដែលបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកអនុវត្តការងារផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។ មានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះឧទាហរណ៍ដែលប្រមូលបានពីកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សរុបមានឯកសារចំនួន ២៥ ត្រូវបានយកមកពិនិត្យសម្រាប់ការសិក្សានេះ។

លទ្ធផលរកឃើញដែលបានពីការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ បានជួយដល់ការរៀបចំបញ្ជីសំណួរសម្រាប់កិច្ចសម្ភាស (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធទី ១)។

ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

ការសម្ភាសត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលបានចូលរួម – ឬដែលអាចផ្តល់ជាគំនិតសំខាន់ៗអំពីការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការសម្ភាសនេះត្រូវបានកំណត់ដោយសមាជិកបណ្តាញ FCF | REACT ទៅតាមពេលវេលានៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ ក្នុងការបង្វែរឬការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ ក្រុមការងារនៃបណ្តាញ FCF | REACT បានទាក់ទងទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំ ចងក្រងមេរៀនជានបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ និងដើម្បីស្នើសុំឱ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។ បន្ទាប់មកក៏មានការស្នើសុំឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្តល់ដំណឹងដល់បុគ្គលិកអំពីពេលវេលា និងវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះ និងបានសួរទៅពួកគេអំពីដំណើរការសម្ភាសន៍ ដូចជា ថាតើពួកគេចង់សម្ភាសជាភាសាអង់គ្លេស ឬមានការបកប្រែជាសាភាខ្មែរ?។

យើងក៏មានជាលិខិតស្នើសុំការសម្ភាសជាផ្លូវការ ដែលត្រូវបានផ្ញើជូនក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដោយយើងមានការសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងចំនួន ០១ រូបមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរ។

ការសម្ភាសសរុបមានចំនួន ១២ លើក ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន ១៩ នាក់ (ជនជាតិខ្មែរចំនួន ១៦ នាក់ /ជនបរទេសចំនួន ៣ នាក់ ដែលមានស្ត្រី ៤៧% និងបុរស ៥៣%) មកពីអង្គការស្ថាប័នចំនួន ១១ ដែល កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដំណើរការទៅក្នុងចន្លោះពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១។ អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួម នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាស គឺជាតំណាងមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បណ្តាញ Better Care Network អង្គការ Cambodia Children's Trust អង្គការ Children's Futures International អង្គការ Friends International អង្គការ Hagar International អង្គការ Holt អង្គការកុមារីកវាយ អង្គការមិត្តសម្លាញ់ អង្គការម្លប់ឫស្សី អង្គការ ជីវិតនៅកម្ពុជា និងអង្គការយូនីសេហ្វ។

ការវិភាគទិន្នន័យ

ក្នុងដំណើរការសម្ភាសនីមួយៗ យើងមានការកត់ត្រាល្អិតល្អន់គ្រប់ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ ហើយក៏មានការថតជាសំឡេងការសម្ភាសផងដែរ ដោយមានការយល់ព្រមឯកភាពពីអ្នកតបសម្ភាស។ កិច្ច សម្ភាសន៍នីមួយៗត្រូវបានធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមអង្គការនីមួយៗ លើកលែងតែអង្គការម្លប់ឫស្សី និង អង្គការ Friends International ដែលការសម្ភាសន៍ធ្វើរួមគ្នា ដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែររយៈពេល ១ និង៣០ នាទី ខុសពីការសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតដែលចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ ១ ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ។ កំណត់កត់ ត្រាកិច្ចសម្ភាសទាំងអស់ត្រូវបានបោះពុម្ពចេញ និងដាក់លេខកូដសម្គាល់ទៅតាមប្រធានបទសំខាន់ៗ ដែលបាន លើកឡើងនៅក្នុងពេលការសម្ភាសទាំងនេះ។ បន្ទាប់មកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្តាប់ការសម្ភាសទាំងអស់ដែល បានថតទុកម្តងទៀត ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានចំណុចណាដែលខ្វះចន្លោះដែរឬទេ? ថាតើចាំបាច់ត្រូវបន្ថែម លេខកូដអ្វីដែរឬទេ និងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីសុក្រឹតភាពនៃសម្រង់សម្តីនានាដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ នេះ។ ការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធបាន ផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់រៀបចំបញ្ជីសំណួរសំខាន់ៗតាំងពីដំបូង ហើយ បន្ទាប់មកឯកសារនីមួយៗត្រូវបានពិនិត្យមើលម្តងទៀត ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងប្រធានបទសំខាន់ៗដែល ត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងនេះ។ បន្ទាប់មកប្រធានបទសំខាន់ៗទាំងនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាចំណងជើងសម្រាប់របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។

ការពិចារណាផ្នែកក្រមសីលធម៌

រាល់ការសម្ភាសទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ លើកលែងតែមានចំណុចជាក់លាក់អ្វីមួយដែល អ្នកពាក់ព័ន្ធចង់ឱ្យបញ្ចូល ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ពុំមានអ្នកតបសម្ភាសណាម្នាក់បានស្នើសុំបែបនេះនោះឡើយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានសុំការយល់ព្រមផ្ទាល់មាត់ ពីអ្នកតបសម្ភាសនីមួយៗ ក៏ដូចជាសុំការយល់ព្រមថតសំឡេងក្នុង ដំណើរការកិច្ចសម្ភាសរបស់ពួកគេផងដែរ។ ខណៈពេលដែលមានការថតសំឡេងក្នុងកិច្ចសម្ភាសទាំងនេះ សម្រាប់គោលបំណងនៃការកត់ត្រា សារសំឡេងទាំងនេះត្រូវបានកម្ទេចចោលបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ត្រូវបាន បញ្ចប់រួចរាល់។

សំណួរត្រូវបានរៀបចំឡើង ជុំវិញការងារដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនេះបានធ្វើជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ ជាជាងជាមួយកុមារម្នាក់ៗ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពកុមារ នោះ ក្តីបារម្ភទាំងនេះនឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់មន្ត្រីបង្គោលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពកុមារ របស់អង្គការ Save the Children ដើម្បីធ្វើការតាមដានបន្តទៀត។ បើទោះជាមានការកំណត់បែបនេះក៏ដោយ ពុំមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពកុមារ ក្នុងដំណើរការសម្ភាសនោះឡើយ។ ពុំមានការសម្ភាសជាមួយកុមារឡើយនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។

ដែនកំណត់ក្នុងការសិក្សា

ការពិនិត្យឡើងវិញនេះ ផ្តោតជាក់លាក់លើបទពិសោធន៍របស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនានាដែលចូលរួមគាំទ្រដល់ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដូច្នេះការពិនិត្យនេះ គឺផ្អែកតែលើការយល់ឃើញរបស់អ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសតែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី មានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានពីការពិនិត្យលើឯកសារមានស្រាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ រាប់បញ្ចូលទាំងករណីសិក្សា ដែលរៀបរៀងឡើងដោយបណ្តាញ Better Care Network និងលទ្ធផលរកឃើញដែលបានពីការសម្ភាសជាក្រុមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចូលរួមរៀបចំគម្រោង FCF កាលពីដើមឆ្នាំ ២០២១ បានគ្របដណ្តប់លើការយល់ឃើញមួយចំនួនរបស់បុគ្គលិក និងនាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារ។

ការសិក្សានេះ ពុំបានពិនិត្យមើលជាក់លាក់លើផលប៉ះពាល់ដែលបង្កដោយជំងឺកូវីដ ១៩ មកលើការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះទេ ប៉ុន្តែចំណុចនេះត្រូវបានលើកយកមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ នៅពេលអ្នកតបសម្ភាសជាច្រើននាក់បានលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនេះ។ លើសពីនេះទៀត នៅក្នុងការសិក្សានេះក៏មានការលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ ១៩ មកលើមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលដំណើរការជាលក្ខណៈឯកជន ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធនេះផងដែរ។[11] ខណៈពេលដែលការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធពិតជាបានរំលេចពីឯកសារពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនក៏ដោយ ពុំមានការសរសេរអត្ថបទច្រើនអំពីប្រធានបទការថែទាំកុមារនេះឡើយ។ មានត្រឹមតែ ២៥ ឯកសារប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចថាមេរៀនបទពិសោធន៍ស្តីពីការថែទាំកុមារ ពុំត្រូវបានគេចងក្រងសម្រាប់បោះពុម្ពផ្សាយ ចងក្រងជាឯកសារ ឬចែករំលែកនោះឡើយ។ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះ តំណាងមកពីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រូវបានផ្តល់បទសម្ភាស ប៉ុន្តែពុំមានមន្ត្រីណាម្នាក់មកពីមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ឬ គ.ក.ន.ក ត្រូវបានសម្ភាសនោះឡើយ ដោយសារ អាចថាពួកគេមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នា ផ្នែកតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេ។

[11] Nhep, R. van Doore, K. (April ២០២១). *Impact of COVID-១៩ on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School.

លទ្ធផលរកឃើញ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្វែរ និងកាបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេស តាមរយៈផែនការសកម្មភាពជាតិ និងការដាក់ចេញនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងគោលនយោបាយ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់កិច្ចការងារនេះជាបន្តបន្ទាប់។

"នៅពេលដែលគោលនយោបាយត្រូវបានដាក់ចេញ ទើបគេដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការថែទាំកុមារ... មណ្ឌលថែទាំកុមារជាច្រើនត្រូវបានជំរុញឱ្យផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការងាររបស់ខ្លួន។" កិច្ចសម្ភាសទី ៨

"ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ជាពិសេសពីថ្នាក់ក្រសួង បាននឹងកំពុងជំរុញការងារនេះ ហើយឥឡូវនេះយើងមាននាយកដ្ឋានជំនាញដែលទទួលបន្ទុកការងារធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ។ មិនយូរទៀតទេ យើងនឹងលែងមានមណ្ឌលថែទាំកុមារទៀតហើយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៩

ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយ ការជោគជ័យក្នុងការបង្វែរ ត្រូវបញ្ចូលសមាសភាគសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយដែលចាំបាច់ត្រូវយកមកធ្វើការពិចារណាក្នុងពេលដំណាលគ្នាដូចជា៖ មូលហេតុដែលកុមារចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ ច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត កត្តាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងថវិកាគាំទ្រពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ តម្រូវការរបស់

កុមារម្នាក់ៗដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ភាពអាចរកបាននៃសេវានៅក្នុងសហគមន៍ ដូចជាសេវាថែទាំជំនួសតាមគ្រួសារ និងសមត្ថភាពផ្តល់ការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសមាហរណកម្ម។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាអ្វីដែលលើកឡើងដោយអង្គការ Faith to Action៖

"ការបង្វែរ មិនមែនត្រឹមតែជាការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះឡើយ។ វាគឺជាការបង្វែរ ទៅរកវិធីបរិបទថ្មីក្នុងការងារផ្តល់ការថែទាំ និងការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសហគមន៍។"[12]

ខណៈពេលដែលសមាជិកនៃបណ្តាញ FCF | REACT ភាគច្រើនដែលបានផ្តល់បទសម្ភាស គាំទ្រឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួនតូច (ពី ១ ដល់ ៥ កន្លែង) ធ្វើការបង្វែរ ឬបិទកន្លែងថែទាំ សមាជិកជាច្រើនគាំទ្រឱ្យមានការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមានសមាជិកម្នាក់គាំទ្រឱ្យមានការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារចំនួន ៥០ ទីតាំង។ ផ្អែកតាមការពិនិត្យលើឯកសារមានស្រាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ និងការសម្ភាសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ មានការលើកឡើងនូវមូលដ្ឋានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង ប្រភេទនៃការគាំទ្រដើម្បីឱ្យការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារដំណើរការទៅបានប្រកបដោយជោគជ័យ ហើយក៏មានលើកឡើងផងដែរពីឧបសគ្គដែលធ្វើឱ្យរារាំងដល់ភាពជោគជ័យនៃការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ អ្នកតបសម្ភាសទាំងអស់បានលើកឡើងលម្អិតពីសារសំខាន់នៃការធ្វើការងារក្នុងភាពជាដៃគូ ជាពិសេស ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិ និងតួនាទីម្ចាស់ជំនួយក្នុងការជួយ ឬអាចបង្អាក់ដល់ដំណើរការបង្វែរនេះ។ អ្នកតបសម្ភាសជាច្រើនបានលើកឡើងពីការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា ចំណុចដែលគេត្រូវពិចារណាសម្រាប់បុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ការកំណត់ក្របខណ្ឌពេលវេលាដែលមានលក្ខណៈប្រាកដច្បាស់លាស់ បញ្ហាប្រឈម និងកត្តាដែលត្រូវធ្វើការគិតគូរពិចារណា ក្នុងករណីបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាបន្ទាន់ និងសារសំខាន់នៃការផ្តល់ការគាំទ្រពីសហគមន៍។ ចំណុចនីមួយៗក្នុងចំណោមចំណុចទាំងអស់ខាងលើនេះនឹងត្រូវលើកមកពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់នៃការសិក្សានេះ។

ភាពជាដៃគូ និងការសម្របសម្រួល

អ្នកតបសម្ភាសទាំងអស់ សុទ្ធតែគូសបញ្ជាក់ពីសារសំខាន់នៃការធ្វើការងារក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិ និងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (ក្រសួង/មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា) ក៏ដូចជា ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រធានមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់ការគាំទ្រនៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកតបសម្ភាសមួយចំនួន អាចរៀបចំភាពជាដៃគូបែបនេះ ក្នុងលក្ខណៈផ្លូវការ តាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរស្ថាប័នរវាងរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល មណ្ឌលថែទាំកុមារ ឬចុះអនុស្សរណៈស្តីពីការយោគយល់គ្នាជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកតបសម្ភាសទាំងនេះ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់តួអង្គនីមួយៗ និងត្រូវ

[12] Faith to Action Initiative. ២០១៦. Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual. Page ១៦.

រៀបចំជាផែនការការងាររួម អមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង នេះផងដែរ។ អ្នកតបសម្ភាសមួយចំនួន បានបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំដោយមានសមាសភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដល់ដំណើរការនេះ និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខណៈពេលដែលអ្នកតបសម្ភាសផ្សេងទៀត ឆ្លុះបញ្ចាំងថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ អាចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់។ អ្នកតបសម្ភាសភាគច្រើន គូសបញ្ជាក់ថា ការសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (កម្រិតស្រុក) គឺមានសារសំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញ និងបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារធ្វើការបង្វែរ។

អ្នកតបសម្ភាសភាគច្រើនលើកឡើងជាក់លាក់ថា ផែនការសកម្មភាពជាតិ និងការប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលថែទាំឱ្យបាន៣០% បានជួយលើកទឹកចិត្តឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារ ចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្វែររបស់ខ្លួន។ អ្វីដែលបានជួយបន្ថែមទៀតនោះ គឺនៅពេលដែលក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ចាប់ផ្តើមដំណើរការអធិការកិច្ច។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកតបសម្ភាសមួយចំនួនបានលើកឡើងផងដែរថា ការកំណត់ចំណុចដៅដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បែបនេះ ធ្វើឱ្យគេពិបាកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះ ហើយនាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួនជួបការលំបាក ក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីធ្វើការបង្វែរកុមារដោយសុវត្ថិភាព។

"ដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះប្រកបដោយជោគជ័យ យើងចាំបាច់ត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ជាដើម។" កិច្ចសម្ភាសទី ៧

"ផ្អែកតាមផែនការប្រតិបត្តិការនេះ ប្រធាន និងសហប្រធាននៃក្រុមការងារ ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ (គ.ក.ន.ក) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងរៀបចំផែនការរួមគ្នាជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន មានបំណងជាក់បញ្ចូលគ្នា តាមរយៈរៀបចំផែនការរួមគ្នា ផ្តល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា...ករណីខ្លះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល និងករណីខ្លះគ្រប់គ្រងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។" កិច្ចសម្ភាសទី ១២

"ខ្ញុំគិតថាអ្វីៗកើតឡើងឆាប់រហ័សនៅពេលនេះ។ ប្រសិនជាមានការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លា ហើយវាពិតជាកើតមានប្រាកដមែន។ ភ្លាមៗយើងពុំបានទទួលជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងត្រូវការនោះឡើយ សូម្បីតែគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះ ពេលគឺគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ យើងក៏មិនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៅពេលចាប់ផ្តើមនោះដែរ... មណ្ឌលថែទាំកុមារខ្លះក៏បានបិទ និងពុំបានទទួលការគាំទ្រអ្វីទាំងអស់។" កិច្ចសម្ភាសទី ៨

ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា ក៏បញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ ក្នុងការជំរុញការចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីជួយឱ្យការបង្វែរអាចដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យ។ តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ រួមមានរាជរដ្ឋាភិបាល កុមារ និងគ្រួសារ ម្ចាស់ជំនួយ បុគ្គលិក និងអ្នកផ្តល់សេវា។[13] ការសម្របសម្រួល មានសារសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារនៅ

[13] Faith to Action Initiative. (២០១៦). Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual.

ប្រទេសកម្ពុជា មានតួអង្គជាច្រើនដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាសុខមាលភាពកុមារ និងកិច្ចការពារកុមារ ដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ជាស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវចម្បង ដោយការផ្តល់សេវាធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។[14] ការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ ១៩ មកលើមណ្ឌលថែទាំកុមារបានរកឃើញថា មណ្ឌលថែទាំកុមារ ៧៦% នៅក្នុងការសិក្សានេះ មានការថយចុះចំនួនកុមារដែលទទួលបានការថែទាំ ដោយមូលហេតុចម្បង គឺការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺកូវីដ ១៩ ដោយប្រើប្រាស់យន្តការការពារ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ឱ្យអនុវត្តកន្លងមក។[15]

បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលជួបប្រទះដំបូងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមាហរណកម្ម គឺដោយសារតែការពុំមានអភិក្រមស្តង់ដារសម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្ម និងពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឱ្យតួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការយូនីសេហ្វ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល បច្ចុប្បន្ន បាននឹងកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការការពារកុមារ ផ្នែកតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (SOP) សម្រាប់ផ្តល់ការការពារដល់កុមារ។ គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ មានការរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនលើកជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ បន្ទាប់ពីមានការរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិស្តីពីច្បាប់កិច្ចការពារកុមាររួចមក។ ច្បាប់នេះ អមជាមួយនឹងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្ម ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ឆ្នាំ២០០០-២០២៦ នឹងជួយបញ្ជាក់បន្ថែមកាន់តែច្បាស់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនានា ជុំវិញការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារ ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារដែលកំពុងទទួលបានការថែទាំពីពួកគេ និងការវិនិយោគលើសេវា និងការគាំទ្រនៅតាមសហគមន៍។ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្ម ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរង់ចាំការអនុម័តពីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្នុងគោលបំណងជួយដល់មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងដៃគូនានា ឱ្យអាចធ្វើសមាហរណកម្មកុមារដោយប្រើប្រាស់អភិក្រមដែលកាន់តែមានសង្គតិភាព។ គោលការណ៍ណែនាំនេះ ក៏អាចជួយដល់ការបង្កើតក្រុមការងារសមាហរណកម្មនៅថ្នាក់ខេត្ត ក្នុងខេត្តគោលដៅផងដែរ ដើម្បីជួយឱ្យការអនុវត្តអភិក្រមទាំងនេះកាន់តែមានលក្ខណៈស្តង់ដារ។[16]

បន្ថែមលើនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (SoP) អនុស្សរណៈស្តីពីការយោគយល់គ្នា និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរស្ថាប័ន អ្នកបតសម្ភាសក៏បានលើកឡើងពីសកម្មភាពអនុវត្ត ដែលអាចជួយគាំទ្រដល់ភាពជាដៃគូផងដែរ។ អ្នកតបសម្ភាសបានលើកឡើងពីសារសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកដែលបានធ្វើការងារនេះ។ កន្លង

---

[14] Better Care Network. (២០២០). Cambodia Country Care Profile. The Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation and the Better Care Network.

[15] Nhep, R. van Doore, K. (April ២០២១). *Impact of COVID-១៩ on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School.

[16] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. (២០១៨). Guideline for the Establishment of Provincial Reintegration Teams (Kandal, Phnom Penh, Preah Sihanouk, Battambang and Siem Reap).

មក ការរៀបចំជាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា និងការបង្កើតក្រុមគាំទ្រ ដែលមានការចូលរួមពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលកំពុងឆ្លងកាត់ដំណើរការនេះ ដើម្បីឱ្យពួកគេរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក។

លើសពីនេះ ការសម្របសម្រួល និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងក៏ត្រូវបានលើកឡើងថា ជាសមាសភាគមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មប្រកបដោយជោគជ័យផងដែរ ដូចជា៖ ការសម្របសម្រួល និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់គ្រងករណី ការតាមដានរកគ្រួសារកុមារ និងការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារកុមារ ក៏ដូចជាការបន្តតាមដាន ចងក្រងឯកសារ និងការវាយតម្លៃផងដែរ។[17]

"យើងមិនអាចធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងបាននោះឡើយ។ យើងធ្វើការរួមគ្នា ជាមួយនឹងក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ មណ្ឌលថែទាំកុមារ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងសហគមន៍។" កិច្ចសម្ភាសទី ១០

"យើងមានជំនឿថា អ្វីដែលសំខាន់ គឺត្រូវធ្វើការងារក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ យើងផ្តល់ឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារនូវគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជាដំណើរការ ហើយពួកគេបានកែសម្រួលប្រព័ន្ធ និងដំណើរការទាំងនេះឱ្យស្របតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ .... ភាពជាដៃគូនេះមានសារសំខាន់ ត្បិតយើងចាំបាច់ត្រូវចូលរួមសហការជាមួយដៃគូ ដែលមានទំនុកចិត្តចំពោះការងារនេះ។" កិច្ចសម្ភាសទី ១៥

"យើងរៀបចំជាការបណ្តុះបណ្តាល ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដើម្បីពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្រ ដែលអ្នកទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ និងដើម្បីឱ្យពួកគេអាចចែករំលែកពីដំណើរការនានា និងឈ្វេងយល់ពីបញ្ហាប្រឈម ... ការធ្វើបែបនេះ មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ យើងមិនធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងនោះឡើយ។ យើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ ហើយយើងមាន មណ្ឌលថែទាំកុមារ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងសហគមន៍តាមរយៈការធ្វើការងាររួមគ្នា។" កិច្ចសម្ភាសទី ១០

"កន្លងមកនៅពេលដែលយើងផ្ទេរករណីអ្វីមួយ យើងត្រូវធ្វើដំណើរ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ យើងអាចផ្ញើឯកសារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅជូនក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។ ការធ្វើបែបនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់។" កិច្ចសម្ភាសទី ១២

"កុមារមួយចំនួនមកពីខេត្តឆ្ងាយៗ មិនមែនមកតែពីខេត្តជិតខាងនោះឡើយ ដែលនេះតម្រូវឱ្យបុគ្គលិករបស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង។" កិច្ចសម្ភាសទី ៩

ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងការបង្កើតចក្ខុវិស័យរួម

ទស្សនទានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងការយល់ឃើញនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារ គឺជាទស្សនទានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ/សង្កាត់ (គ.ក.ន.ក) និងកុមារខ្លួនឯង។ នេះគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងដំណើរការបង្វែរ ដែលអ្នកតបសម្ភាសលើកឡើងថា

[17] Wedge, J. 2012. Reaching for Home: The Interagency Group on Reintegration. Global Learning on Family Reintegration in Low and lower-middle income Countries. GHR Foundation.

ត្រូវការពេលយូរជាងគេ។ ដៃគូមិនមែនរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើន ចាប់ផ្តើមសហការជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដូចជា តាមរយៈការរៀបចំជាកិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ដែលពួកគេអាចធ្វើការពិភាក្សាពីបញ្ហានានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំកុមារនៅក្នុងមណ្ឌល និងបង្ហាញពីករណីសិក្សារបស់អង្គការដទៃទៀត ដែលបានឆ្លងកាត់ការបង្វែរកន្លងមក ដែលជាធម្មតា កិច្ចប្រជុំទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយតំណាងមកពីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ឬមន្ទីរសេដ្ឋមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលពួកគេធ្លាប់សហការ ឬធ្វើការជាមួយកន្លងមក។ អង្គការមួយចំនួនទៀត បានចែករំលែកការសិក្សាដែលរំលេចឱ្យឃើញពីគ្រោះថ្នាក់ ដែលបង្កឡើងដោយសារការដាក់កុមារទទួលការថែទាំក្នុងមណ្ឌល ខណៈពេលដែលអង្គការដទៃទៀតបានចែករំលែកពីករណីសិក្សា ឬរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ ឬអ្នកថែទាំដែលបានធ្វើការបង្វែរកុមារចេញទៅក្រៅមណ្ឌលថែទាំ ខណៈពេលដែលអង្គការផ្សេងទៀតផ្តោតលើគំរូធុរកិច្ច (business model) និងបង្ហាញពីហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ នេះធ្លុះបញ្ចាំងពីមូលហេតុ ដែលបង្ហាញចេញពីការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសករណីសិក្សាជាច្រើន[18] ដែលបង្ហាញពីកត្តាផ្សេងៗគ្នាដែលជាកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្ត ប្រធានមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាដែលនាំឱ្យពួកគេផ្លាស់ប្តូរទស្សនរបស់ពួកគេ។ អង្គការមួយចំនួនបានធ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងបារម្ភអំពីគំរូធុរកិច្ចនេះ ខណៈពេលដែលអង្គការផ្សេងទៀតទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត នៅពេលដែលស្តាប់ឮកុមារដែលជីវិតត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន តាមរយៈដំណើការនេះ ឬអ្នកដែលគ្រាន់តែចាំបាច់ត្រូវដឹង ថាតើការបង្វែរកុមារនឹងកើតឡើងបែបណា ហើយត្រូវការឮឧទាហរណ៍មួយចំនួនពីអ្នកដែលបានធ្វើបង្វែរកុមារប្រកបដោយជោគជ័យ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួន ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីបានស្តាប់លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដែលរំលេចឱ្យឃើញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការដាក់កុមារឱ្យទទួលបានការថែទាំនៅក្នុងមណ្ឌល។ នៅក្នុងករណីសិក្សានីមួយៗនៅក្នុងចំណោមករណីសិក្សាទាំងនេះ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកធ្វើការងារជាមួយនឹងប្រធានមណ្ឌលថែទាំកុមារ អាចយល់ពីកត្តាលើកទឹកចិត្ត និងក្តីបារម្ភរបស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ ដើម្បីរៀបចំសាររបស់ខ្លួន ឱ្យផ្តោតចំគោលដៅ និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ សៀវភៅណែនាំស្តីពីការបង្វែរកុមារទៅរកការថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារ ក៏បញ្ជាក់ពីចំណុចនេះផងដែរ ដោយក្នុងនោះមួយផ្នែកនិយាយពីការស្គាល់ក្រុមគោលដៅរបស់អ្នក អ្វីដែលលើកទឹកចិត្តពួកគេ និងក្តីបារម្ភដែលពួកគេអាចមាន។[19]

"ការកំណត់រកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែល មានការប្តេជ្ញាចិត្តពិតជាប្រាកដមែន។ ប្រសិនបើពួកគេមិនធ្លាស់លាស់ទេ វាពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ ហើយអ្នកនឹងចំណាយធនធានច្រើន ដោយពុំបានទទួលលទ្ធផលអ្វីមកវិញសោះ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៧

---

[18] Better Care Network. ២០២១. A Case Study of the Process of Change: Transitioning Firefly Orphanage. Better Care Network and Kinnected; Better Care Network. ២០២១. A Case Study of the Process of Change: Bridges Safehouse. Better Care Network and Kinnected.

[19] Faith to Action Initiative. (២០១៦). Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual.

"យើងអាចជួយបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឡើងវិញដល់បុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ប៉ុន្តែម្ចាស់ជំនួយ ឬក្រុមប្រឹក្សាកិបាលចាំបាច់ត្រូវតែចង់ឱ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឡើងវិញបែបនេះ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៣

"យើងមានមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយដែលចង់ចូលរួមធ្វើការបង្វែរកុមារជាមួយយើង។ យើងបាននឹងកំពុងធ្វើការងារជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារនេះរយៈពេល ២ ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់តែកម្មវិធីសមាហរណកម្មប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការងាររួមគ្នា វាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់។ គាត់នឹងនិយាយទៅប្រាប់ម្ចាស់ជំនួយអំពីសកម្មភាពថ្មីៗដែលគាត់គិតឃើញ។ គាត់បានរៀបចំផែនការអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីការបង្វែរកុមារ ហើយគាត់បានយកផែនការនេះទៅពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ជំនួយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៩

"វប្បធម៌មានឥទ្ធិពលជាងគោលនយោបាយ។ ប្រសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំ ថាតើអ្វីទៅជាភាពជោគជ័យធំបំផុតនោះ វាគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារទទួលស្គាល់អំពីសារសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់កុមារក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត...។ ការធ្វើបែបនេះទើបវប្បធម៌មានការផ្លាស់ប្តូរ ដែលជំរុញឱ្យមានការបង្វែរ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៥

ចំណុចមួយទៀត ដែលធ្វើឱ្យការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារទទួលបានជោគជ័យ គឺការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់សមាជិកសហគមន៍ មិនត្រឹមតែផ្នត់គំនិតរបស់របស់សមាជិក គ.ក.ន.ក ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្នត់គំនិតរបស់ឪពុកម្តាយ និងកុមារផងដែរ។ អ្នកតបសម្ភាសជាច្រើននាក់ បានលើកឡើងពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ គ.ក.ន.ក ក្នុងការទុកដាក់កុមារ និងគាំទ្រដល់កិច្ចការពារកុមារ។ អ្នកតបសម្ភាសជាច្រើនគិតថា ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់ គ.ក.ន.ក គឺជាគន្លឹះដើម្បីផ្តល់កិច្ចការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការយកកុមារមកទុកដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារដោយមិនចាំបាច់តាំងពីដំបូង។

"គ.ក.ន.ក គឺជាយន្តការការពារសុវត្ថិភាពកុមារ។ ពួកគេ គឺជាអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារជាមួយពួកគេ ដើម្បីបញ្ឈប់មិនឱ្យមានការយកកុមារមកដាក់ឱ្យស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៧

អ្នកតបសម្ភាសដទៃទៀតបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ឪពុកម្តាយ អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសារការដាក់កុមារឱ្យស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្តល់សេវាថែទាំតាមគ្រួសារក្នុងសហគមន៍ ហើយក្រោយពេលដែលកុមារបាននៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយរយៈពួកគេអាចត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួន ដើម្បីសម្របខ្លួន ទើបអាចទៅរស់នៅជាមួយសមាជិកគ្រួសារ ឬក្នុងសហគមន៍វិញ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកតបសម្ភាសដទៃទៀតគិតថា ការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដនឹងកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជា នៅពេលដែលឪពុកម្តាយ ឬអ្នកផ្តល់ការថែទាំ ចាប់ផ្តើមទាមទារយកកូនរបស់ពួកគេមកផ្ទះវិញ និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រការងារចេញពីការផ្តោតលើការសហការជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ ក្នុងការបង្វែរកុមារ ទៅផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការផ្តល់ការគាំទ្រ និងផ្តល់សេវានៅក្នុងសហគមន៍វិញ។

"កុមារក็ធ្លាប់តែទទួលបានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ ហើយទាំងនេះ ធ្វើឱ្យរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេមានការប្រែប្រួល។ ពួកគេពិបាករស់នៅក្នុងសហគមន៍។ ដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវជួយដល់កុមារដែលចាកចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ។" កិច្ចសម្ភាសទី ១០

"បញ្ហាប្រឈម គឺគ្រួសារខ្លួនឯង។ ពួកគេនៅតែជឿថាមណ្ឌលថែទាំកុមារ គឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ។ បើទោះជាពួកគេអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់កុមារក็ដោយ ពួកគេនៅតែជឿថាមណ្ឌលថែទាំកុមារ គឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៤

"នៅពេលដែលយើងគិតពីកុមារដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ វាជារឿងប្រសើរសម្រាប់ពួកគេ ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្មពួកគេទៅក្នុងគ្រួសារវិញ យើងមានវិធីតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីជួយដល់ពួកគេ។ នេះ គឺជាអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងកន្លងមក។ ប្រសិនបើកុមាររស់នៅក្នុងគ្រួសារ ដូច្នេះយើងនៅតែអាចរិះរកផ្លូវថ្មី ពោលគឺវិធីសាស្ត្រថ្មីៗ ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេបន្តនៅក្នុងគ្រួសារ។" កិច្ចសម្ភាសទី ១០

បើតាមអង្គការ FHI360 ដែលបានរៀបចំឯកសារសិក្សារៀនសូត្រ ដែលងាយស្រួលយល់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីរបៀបរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសង្គម តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង[20] ដំបូងគេចាំបាច់ត្រូវឈ្វេងយល់ពីចំណេះដឹងដែលនៅខ្វះចន្លោះសិន ទើបគេអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវិភាគនេះ និងរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមគោលដៅជាក់លាក់នីមួយៗ ដែលអង្គការណាមួយព្យាយាមធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលលើវា។ ខ្លឹមសារសង្ខេបអាចជួយឱ្យអ្នកជំនាញកំណត់ដឹងពីក្រុមគោលដៅ អ្វីដែលពួកគេចង់ឱ្យក្រុមគោលដៅ (ពោល គឺនាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ឬកុមារ និងគ្រួសារ) ធ្វើខុសពីមុន កត្តាដែលរារាំងពួកគេមិនឱ្យអនុវត្តតាមឥរិយាបថដែលចង់បាន កត្តាដែលលើកទឹកចិត្តពួកគេ និងទីកន្លែងដែលពួកគេអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលពួកគេជឿទុកចិត្ត។

ឧទាហរណ៍ខ្លឹមសារសង្ខេបសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងស្តីពីការបង្ហែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ

ក្រុមគោលដៅ	អ្វីដែលយើងចង់ឱ្យពួកគេធ្វើ?	ហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនកំពុងអនុវត្តតាមឥរិយាបថទាំងនេះ?	តើយើងលើកទឹកចិត្តពួកគេដោយរបៀបណា?	តើពួកគេទទួលបានព័ត៌មានដែលពួកគេជឿទុកចិត្តពីទីណា?
នាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារ	ការបង្ហែរកុមារមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់ពួកគេ ទៅជា	មិនច្បាស់ថាតើត្រូវធ្វើបែបណា ខ្លាចបាត់បង់ចំណូល	ចង់ធ្វើអ្វីដែលកាន់តែប្រសើរ	គ.ក.ន.ក អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀត

[20] FHI360 C-Modules: https://www.fhi360.org/resource/c-modules-learning-package-social-and-behavior-change-communication

	ការផ្តល់សេវាតាមសហគមន៍វិញ		បង្ហាញពួកគេពីវិធីសាស្ត្រដែលមណ្ឌលថែទាំកុមារដទៃទៀត អាចធ្វើបង្វែរប្រកបដោយជោគជ័យ ជួយដល់ពួកគេក្នុងការជំរុញការសហការពីអ្នកផ្តល់ជំនួយរបស់ពួកគេ	ព្រះវិហារប្រសិនបើជាអង្គការសាសនា
សមាជិកគ្រួសារ	ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ និងជួយដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកូនៗរបស់ពួកគេ	យល់មិនត្រឹមត្រូវពីអត្ថប្រយោជន៍នៃមណ្ឌលថែទាំកុមារ ខ្វះសេវានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ	ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ គ្រោះថ្នាក់ដែលបង្ករឡើងដោយសារការដាក់កុមារឱ្យស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងសហគមន៍ (សកម្មភាពរកចំណូល ឧបត្ថម្ភថ្លៃសេវាអប់រំ ។ល។)	ទីផ្សារ សមាជិកគ្រួសារ

បន្ទាប់ពីបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និងបង្កើតសារអប់រំរួច អង្គការស្ថាប័ននេះចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកមតិត្រឡប់ពីក្រុមគោលដៅ និងសហគមន៍ ដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើពួកគេពិតជាយល់សារអប់រំទាំងនេះដែរឬទេ? និងថាតើសារអប់រំទាំងនេះ ពិតជានាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរដែលចាំបាច់ដែរឬទេ។ សារសំខាន់នៃការពិនិត្យឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ លើយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសង្គម តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដែលបានបង្ហាញថាយុទ្ធនាការនោះហាក់បីដូចជាពុំមានឥទ្ធិពលលើជំនឿរបស់អ្នកឆ្លើយតប ថាតើមណ្ឌលថែទាំកុមារពិតជានាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់មែនដែរឬទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី យុទ្ធនាការនោះពិតជាជះឥទ្ធិពលលើអ្នកឆ្លើយតបថាតើពួកគាត់មានឬមិនមានគំនិតថាមណ្ឌលថែទាំកុមារអាចបង្កអន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្ত និងសុខមាលភាពផ្លូវកាយរបស់កុមារ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្តល់អ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកជាអនុសាសន៍ថា យុទ្ធនាការនាពេលអនាគតដែលផ្តោតលើសមាជិកសហគមន៍ គួរតែផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត អំពីហេតុផលដែលមណ្ឌលថែទាំកុមារអាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារ។[21] ការសិក្សាលើឥរិយាបថចំពោះការថែទាំកុមារក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងអង្គការយូនីសេហ្វ ឆ្លុះបញ្ចាំងលើទស្សនយល់ឃើញខាងលើនេះ។ ការសិក្សានេះ បង្ហាញថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងមេភូមិ ៧១% គិតថាការថែទាំកុមារក្នុងមណ្ឌល គឺជាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមារដែលពុំមានឪពុកម្តាយ ហើយ ៨៤% យល់ស្របថា គ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រ គួរបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគេទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដើម្បីទទួលបានការអប់រំ ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសាលានៅក្នុងភូមិ។ នៅក្នុងការសិក្សានេះ មានមេភូមិតិចនាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្លាប់

[21] USAID. ២០១៨. Rapid Feedback MERL & Cambodian Children's Trust Final Learning Check. Powerpoint Presentation.

បានឮពីជម្រើសផ្តល់ការថែទាំកុមារនៅក្នុងសហគមន៍ ប៉ុន្តែពួកគេគិតថា ប្រសិនបើមានជម្រើសទាំងនេះមែន នោះ វាពិតជាផ្តល់នូវវិជ្ជមានដល់កុមារជាមិនខាន។ ខណៈពេលដែលមានគ្រួសារ ៦១% យល់ស្របថា ការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ គឺជាជម្រើសដែលល្អប្រសើរជាងសម្រាប់កុមារ គ្រួសារ ៨៥% ក៏យល់ស្របផងដែរថា កុមារដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានទទួលការអប់រំប្រសើរជាង បើធៀបនឹងកុមាររស់នៅក្នុងភូមិ ហើយការអប់រំ និងការយល់ឃើញពីអនាគតកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កុមារ មានលើសពីគុណសម្បត្តិនៃការផ្តល់ការថែទាំដល់កុមារនៅតាមគ្រួសារ។[22] ខណៈពេលដែលយុទ្ធនាការជាសាធារណៈ បានចាប់ផ្តើមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតបែបនេះ និងបានកៀរគរការគាំទ្រមតិពីសាធារណៈជន ដល់ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ បច្ចុប្បន្ននេះពុំមានទិន្នន័យបង្ហាញថាផ្នត់គំនិតទាំងនេះបានផ្លាស់ប្តូរនោះឡើយ។ ការអង្កេតដើមគ្រាមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ ២០១៩ ស្របពេលដែលយុទ្ធនាការរក្សាគ្រួសារឱ្យនៅជុំគ្នា ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាថ្មី មានសមាជិកសហគមន៍តែ ១៧% ប៉ុណ្ណោះ ដែលយល់ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការដាក់កុមារឱ្យស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។

ការគាំទ្ររបស់សហគមន៍

មានការយល់ស្របជាទូទៅលើភាពចាំបាច់នៃការផ្តល់សេវា និងគាំទ្របន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ ជាពិសេសផ្តោតលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់គ្រួសារ ជាពិសេសគ្រួសារដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្ទួនៗ ដូចជា៖ ការថែទាំកុមារដែលមានពិការភាព ឬកុមារដែលរស់នៅជាមួយមេរោគ/ជំងឺអេដស៍ ជាដើម។ ខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ជារឿយៗត្រូវការការគាំទ្រពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល កន្លងមកមានការអនុវត្តសកម្មភាពការងារជាច្រើន ដើម្បីបង្កើនថវិការសេវាសង្គមសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ ដូចដែលត្រូវបានរំលេចនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីចំណាយលើសេវាសង្គមកាលពីឆ្នាំ ២០១៨។[23] ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកតបសម្ភាសម្នាក់ (កិច្ចសម្ភាសទី ១២) បានកត់សម្គាល់ថា ចំណុចខ្វះខាតនៅតែបន្តមាន ត្បិតគោលនយោបាយស្តីពីជំនួយសង្គម ផ្តោតតែលើគ្រួសារដែលមានកូនអាយុក្រោម២ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ហើយខណៈពេលដែលមានការជួយគាំទ្រមួយចំនួនដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារចេញពីមណ្ឌល ថែទាំកុមារពីរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលគេពុំមានថវិកាសម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្មកុមារទាំងអស់នោះឡើយ។

"កន្លងមកយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា ដែលធ្វើឱ្យយើងខកខានពុំបានអនុវត្តសកម្មភាពបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងអន្តរាគមន៍ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ សកម្មភាពទាំងនេះអស់ចំណាយតិចជាងច្រើន ប៉ុន្តែផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អប្រសើរជាង។ នោះប្រហែលជា ការវិត្តន៍តាមធម្មជាតិ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៣

---

[22] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. ២០១១. With the Best Intentions: Attitudes Towards Residential Care in Cambodia.

[23] Better Care Network. (២០២០). Cambodia Country Care Profile. The Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation and the Better Care Network.

"ប្រសិនបើយើងចង់បានសេវាថែទាំនៅតាមសហគមន៍ យើងត្រូវការសេវាសម្រាប់កុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ហើយសេវាទាំងនេះត្រូវតែមាននិរន្តរភាព។ ប្រសិនបើសេវាទាំងនេះពុំមាននិរន្តរភាពនោះទេ ពោល គឺបានត្រឹមតែ ១ ឆ្នាំ ឬ ២ ឆ្នាំនោះ ពេលនោះយើងនឹងលែងមានថវិការទៀត ហើយកុមារនៅតែត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រ តើពួកគេគួរធ្វើបែបណា ? យើងចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ពីសេវាដែលត្រូវផ្តល់ដល់កុមារទាំងនេះ... ហើយយើងចាំបាច់ត្រូវជួយឱ្យពួកគេ [គ្រួសារ] ទទួលបានប្រាក់ចំណូលឱ្យបានច្រើន។" កិច្ចសម្ភាសទី ១២

"អ្នកចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយតបចំពោះមូលហេតុដែលគេយកកុមារទាំងនេះទៅទុកដាក់នៅមណ្ឌលថែទាំកុមារពីដំបូង ហើយប្រសិនបើអ្នកពុំបានឆ្លើយតបចំពោះមូលហេតុដែលជាឫសគល់នៃបញ្ហានោះទេ អ្នកនឹងមិនអាចសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពនោះឡើយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៣

"យើងបានបង្កើនការគាំទ្រដល់ការថែទាំដោយឪពុកម្តាយធម៌ក្នុងសហគមន៍របស់យើង ដូច្នេះ ប្រសិនបើអតិថិជនដទៃទៀតពុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាន ពួកគេអាចទទួលបានការថែទាំដោយឪពុកម្តាយធម៌។" កិច្ចសម្ភាសទី ៦

"យើងត្រូវការកម្លាំងជំរុញពីក្រោមទៅលើ ដែលក្នុងនោះគ្រួសារទទួលបានការគាំទ្រ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចមើលថែទាំកូនដោយខ្លួនឯង។ ឥឡូវនេះពួកគេគិតថាមណ្ឌលថែទាំកុមារ អាចផ្តល់ការគាំទ្របានប្រសើរជាង។ ពួកគេមិនមែនធ្វើបែបនេះ ដោយសារតែខ្វះក្តីស្រឡាញ់ ឬពុំមានសមត្ថភាពមើលថែទាំកូននោះឡើយ។ ការធ្វើបែបនេះទទួលបានជោគជ័យប្រសើរជាងការជំរុញពីលើមកក្រោម។" កិច្ចសម្ភាសទី ៣

តួនាទីរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ

ខណៈពេលដែលការងារភាគច្រើនដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើ ផ្តោតលើអ្នកគ្រប់គ្រង និងនាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារ អង្គការស្ថាប័នជាច្រើនដែលត្រូវបានសម្ភាស នៅតែជួបការលំបាកក្នុងការជំរុញការចូលរួមសហការពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ។ នេះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយ ដែលអង្គការស្ថាប័នជាច្រើនជួបប្រទះនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមជួយមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងការបង្វែរ។ នេះគឺជាមូលហេតុដែលលើកឡើងញឹកញាប់ជាងគេ ដែលធ្វើឱ្យដំណើរការបង្វែររបស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ ពុំអាចមានភាពជឿនលឿនទៅមុខទៀត។ អ្នកផ្តល់ជំនួយនៅក្រៅប្រទេស គឺជាអ្នកផ្តល់ថវិកាគាំទ្រធំជាងគេដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជា។ បើតាមការសិក្សាលើឥរិយាបថចំពោះការទុកដាក់កុមារឱ្យទទួលបានការថែទាំនៅក្នុងមណ្ឌល ថវិកាគាំទ្រដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារស្ទើរតែ១០០% មានប្រភពពីក្រៅប្រទេស។ ខណៈពេលដែលជនជាតិកម្ពុជាមួយចំនួនបានបើកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ពួកគេក៏ពឹងអាស្រ័យលើថវិកាគាំទ្រពីក្រៅប្រទេសផងដែរ។[24] មណ្ឌលថែទាំកុមារជាច្រើនប្រើប្រាស់សេវាទេសចរណ៍ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកផ្តល់មូលនិធិ។ មណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួនរំអង្គាសថវិកាពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ឬពីព្រះវិហារ ដោយហេតុថាពួកគេមួយចំនួនពឹងអាស្រ័យតែលើសប្បុរសជនតែម្នាក់ ឬពីនាក់ប៉ុណ្ណោះ។

[24] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. ២០១១. With the Best Intentions: Attitudes Towards Residential Care in Cambodia.

"យើងផ្តល់សេវាសមាហរណកម្ម ប៉ុន្តែមណ្ឌលថែទាំកុមារនីមួយៗពឹងអាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់ជំនួយ។ ពួកគេត្រូវមានទំនុកចិត្តហ៊ាននិយាយទៅកាន់អ្នកផ្តល់ជំនួយ។ អ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារត្រូវមានទំនុកចិត្ត និងចេះពន្យល់ ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប្រសិនបើខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរទិសដៅរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តថាអ្នកនឹងនៅតែបន្តជួយដល់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនោះឡើយ។ ពួកគេពឹងអាស្រ័យខ្លាំងលើទេសចរណ៍ និងភ្ញៀវ និងលើការយល់ដឹង និងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអ្នកផ្តល់ជំនួយទាំងនេះ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៩

"ខ្ញុំគិតថា វាគឺជាបញ្ហា ប្រសិនបើចង់ឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងអស់ធ្វើការ 'ផ្លាស់ប្តូរផែនការរបស់ពួកគេ' ខ្ញុំប្រើពាក្យថា 'ផ្លាស់ប្តូរផែនការរបស់ពួកគេ' ពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ល្អឡើយ ព្រោះថាអ្នកផ្តល់ជំនួយរបស់ពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើមានមណ្ឌលថែទាំកុមារ ពួកគេជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រ ប្រសិនបើពួកគេមិនមានមណ្ឌលថែទាំកុមារទេ ពួកគេនឹងលែងផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រទៀតហើយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ១២

"ពួកគេពិបាករកអង្គាសថវិកាគាំទ្រ ពេលដែលកុមារស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកុមារស្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍។ វាពិបាកនឹងពន្យល់ឱ្យមនុស្សភាគច្រើនយល់ ហើយជាការពិតអ្នកផ្តល់ជំនួយពុំបានដឹងថាកុមារទាំងនេះមិនមែនជាកុមារកំព្រានោះឡើយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៣

"ពួកគេ [អ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ] បានផ្លាស់ប្តូរការប្តេជ្ញាចិត្ត និងផែនការរបស់ពួកគេ ត្បិតអ្នកផ្តល់ថវិកាគាំទ្រ និងក្រុមប្រឹក្សាកិបាលរបស់ពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនោះឡើយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៧

"ចំណុចធំជាងគេដែលកើតមានក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៅក្នុងពិភពលោក គឺមណ្ឌលថែទាំកុមារកាន់តែបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការ។ ពួកគេធ្លាប់តែពឹងអាស្រ័យលើភ្ញៀវដែលមកកាន់មណ្ឌលរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ពួកគេពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើអ្នកផ្តល់ជំនួយ។ យើងចាំបាច់ត្រូវកសាងសមត្ថភាពឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារហ៊ាននិយាយទៅកាន់អ្នកផ្តល់ជំនួយ ... ពេលគឺមិនមែនត្រឹមតែអ្នកផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអ្នកផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៩

មានឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថា មានការចាប់ផ្តើមធ្វើការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងនាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ហើយលែងមានទៅវិញ ដោយសារតែអ្នកផ្តល់ជំនួយមិនចាប់អារម្មណ៍ ឬមិនផ្តល់ការគាំទ្រ។ លើសពីនេះ ក៏មានការលើកឡើងពីប្រភេទអ្នកផ្តល់ជំនួយមួយចំនួនផងដែរ ដោយមានការពន្យល់ថាអ្នកផ្តល់ជំនួយទាំងនេះ ពិបាកធ្វើការងារជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលជំណើរការក្រៅប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជាជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលពឹងអាស្រ័យលើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអ្នកផ្តល់ជំនួយជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ មណ្ឌលថែទាំកុមារដែលបានធ្វើការបង្វែរ រាប់បញ្ចូលទាំងមណ្ឌលដែលបានធ្វើការបង្វែរដោយខ្លួនឯងផងនោះ សុទ្ធតែបានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ឬអាចមានលទ្ធភាពស្វែងរកអ្នកផ្តល់ជំនួយផ្សេងទៀត។ ក្នុងឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញពីជោគជ័យនៃការបង្វែរ នាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារសុទ្ធតែមានទំនុកចិត្តក្នុងការរកអង្គាសថវិកាដោយខ្លួនឯង ហើយក៏ជាអ្នកដែលមានចក្ខុវិស័យយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការថែទាំកុមារនៅតាមសហគមន៍ដែលជាគំរូធុរកិច្ចថ្មីនៃមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់ពួកគេ។ ចំណុចសំខាន់ នៃការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំងកុមារ ទាមទារឱ្យមានគំរូធុរកិច្ចថ្មី។ អង្គការ Faith to Action បានលើកឡើងថា ទន្ទឹមនឹងការមានផែនការ និងចក្ខុវិស័យ អ្វីដែល

សំខាន់ផងដែរនោះ គឺត្រូវពិនិត្យលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស ក៏ដូចជាធនធានដែលចាំបាច់ ដើម្បីជួយគាំទ្រឱ្យដំណើរការបង្វែរមាននិរន្តរភាពទៅមុខទៀត។[25] អ្នកផ្តល់ជំនួយ គឺជាដៃគូដ៏ជាក់ច្បាស់ក្នុងដំណើរការបង្វែរនេះ ដែលនេះអាចនាំឱ្យមានការលំបាកខ្លាំងដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ព្រោះថាប្រធានមណ្ឌលថែទាំកុមារអាចខំការពារខ្លួន និងមិនបង្ហាញតម្លាភាពអំពីអ្នកផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួន និងពីទម្រង់នៃការផ្តល់ថវិកាគាំទ្ររបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយទាំងនោះ។

លើសពីនេះ ក៏មានការលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលត្រូវបិទទ្វារបន្ទាន់ ព្រោះខ្វះថវិកា ឬខ្វះការឧបត្ថម្ភពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ដែលនាំឱ្យមានវិបត្តិសម្រាប់កុមារដែលកំពុងទទួលបានការថែទាំពីមណ្ឌលទាំងនោះ។ មណ្ឌលថែទាំកុមារជារឿយៗ ដំណើរការដោយពុំមានស្តេរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលវែងនោះឡើយ ហើយអ្នកផ្តល់ជំនួយមួយចំនួនបារម្ភថា ថវិកាដែលផ្តល់ទៅឱ្យគ្រួសារនឹងមិនត្រូវបានចំណាយលើកុមារនោះឡើយ។[26] សូម្បីតែមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលបានធ្វើការបង្វែររួចក៏ដោយ ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថា ការអែង្គាសថវិកាសម្រាប់ការថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ និងក្នុងសហគមន៍អាចពិបាកជាង ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ជំនួយធ្លាប់តែអនុវត្តគំរូផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យពួកគេបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកុមារណាម្នាក់នោះ។

ការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩ ដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារ បានរកឃើញថា ការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពអែង្គាសថវិកា និងសមត្ថភាពទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីប្រភពផ្សេងៗសម្រាប់ដំណើរការបង្វែរ គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធ្វើការកំណត់ថាតើអ្នកចូលរួមពិតជាចង់ និងពិតជាអាចពិចារណាផ្លាស់ប្តូរគំរូនៃការផ្តល់ការថែទាំរបស់ពួកគេ រាប់បញ្ចូលទាំងដំណើរការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារផង។ អ្នកចូលរួម ៨១% ដែលត្រូវបានសាកសួរនៅក្នុងការសិក្សា លើផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ ១៩ មកលើមណ្ឌលថែទាំកុមារបានលើកឡើងថា ការផ្តល់ថវិកាគាំទ្រពិតជាទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដូចជា លទ្ធភាពរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អែង្គាសប្រាក់ នៅទីសាធារណៈ ឬការរៀបចំទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ឬភ្ញៀវមកកាន់មណ្ឌលថែទាំរបស់ពួកគេជាដើម។ ការសិក្សានេះក៏បានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ពីកម្ពុជា ដែលលើកឡើងថា ការអនុវត្តវិធានការតឹតតឹតក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺកូវីដ ១៩ ធ្វើឱ្យនាយកមណ្ឌលកុមារកំព្រា កាន់តែអាចឈ្វេងយល់ពីលទ្ធភាពផ្តល់ការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ និងការធ្វើសមាហរណកម្មរយៈពេលវែង។[27]

ដោយសារតែអ្នកផ្តល់ជំនួយអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំង លើជោគជ័យនៃការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ការបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការចូលរួមសហការពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ដើម្បីអាចកសាងភាពជាដៃគូឱ្យបានកាន់តែរឹងមាំ ជាមួយនឹងក្រុមតស៊ូមតិនៅតាមប្រទេសផ្តល់ជំនួយ និងចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើម ស្រដៀងគ្នា

---

[25] Faith to Action Initiative. (២០១៦). Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual.

[26] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. ២០១១. With the Best Intentions: Attitudes Towards Residential Care in Cambodia.

[27] Nhep, R. van Doore, K. (April 2021). *Impact of COVID-19 on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School

នេះ ដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រា ដូចជាជាមួយនឹងយុទ្ធនាការទេសចរណ៍សុវត្ថិភាពកុមារ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងទេសចរណ៍ជាដើម។

ការពិចារណាអំពីបុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ

ការបារម្ភធំៗជាងគេ ដែលអ្នកតបសម្ភាសបានលើកឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិក និងប្រធានមណ្ឌលថែទាំកុមារ គឺការបារម្ភរឿងគំរូផ្តល់ថវិកាគាំទ្រ និងតួនាទីរបស់បុគ្គលិក។ មណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួនប្រើប្រាស់ថវិកាគាំទ្រ ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលឡើងវិញដល់បុគ្គលិក ឬប្តូរពួកគេទៅធ្វើសកម្មភាពតាមសហគមន៍វិញ។ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានជួយបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ អំពីការគ្រប់គ្រងករណីបច្ចេកទេសធ្វើសមាហរណកម្ម ការថែទាំដោយឪពុកម្តាយធម៌ និងរបៀបគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងបំពេញទម្រង់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កុមារម្នាក់ៗ។ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន បានចូលរួមផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឡើងវិញទាំងស្រុងដល់បុគ្គលិក ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចចាប់យកអាជីពផ្សេងទៀត។ អ្នកតបសម្ភាសភាគច្រើនគិតថា ការវិនិយោគលើបុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ធ្វើឱ្យដំណើរការបង្វែរមានភាពងាយស្រួលច្រើន ហើយការក៏បានជួយឱ្យគាំទ្រឱ្យមានភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងករណី និងអ្នកថែទាំប្រកបដោយជំនាញនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងដំណាក់កាលនៃការបង្វែរនេះផងដែរ។

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្នុងការងារពង្រឹងកម្លាំងភ្នាក់ងារសង្គម តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្អែកលើសមត្ថភាព។ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច (NISA) បានផ្តល់ការឯកភាពដល់មេរៀនសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល និងផែនការបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងសេវាសង្គមសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ នៅក្នុងការសម្ភាសជាក្រុមជាមួយបុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចូលរួមរៀបចំគម្រោង FCF អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាបានលើកឡើងពីតម្រូវការគាំទ្រ ដើម្បីជួយដល់ការតាមដានរកគ្រួសារ ក៏ដូចជាការគាំទ្រសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារ និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ។[28]

"យើងអាចដឹងពីផលប៉ះពាល់ក្នុងការដាក់កុមារឱ្យស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមកលើកុមារ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរស់នៅជួបជុំជាមួយគ្រួសារ។ ពួកគេ [អង្គការដែលជួយដល់ដំណើរការបង្វែរ] ត្រូវដឹងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវចេះពន្យល់ពីចំណុចទាំងនេះ ទៅកាន់មណ្ឌលថែទាំកុមារផងដែរ។ ពួកគេក៏ចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ផងដែរ ថាតើការងាររបស់ពួកគេនឹងនៅតែបន្តមានតាមរបៀបណា។" កិច្ចសម្ភាសទី ៩

"មណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួនបារម្ភអំពីការងាររបស់ពួកគេ។ បុគ្គលិកអាចបាត់បង់ការងារ ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតការងារគម្រោងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រធានមណ្ឌលថែទាំកុមារ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៥

"ខ្ញុំដឹងថាវាជារឿងលំបាកសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើង។ យើងត្រូវកាត់បុគ្គលិកមួយចំនួន ហើយពួកគេជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើនក្នុងការរកចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ... យើងជួយឱ្យពួកគេរកការងារបានធ្វើ និងផ្តល់ការធានា ក៏

---

[28] ការពិភាក្សាជាក្រុមជាមួយនឹងមណ្ឌលថែទាំកុមារ – បទបង្ហាញលទ្ធផលរកឃើញនៃការពិភាក្សាជាក្រុមអំពីការរួមគ្នារៀបចំ (Co-Design) ឆ្នាំ ២០២១។

ដូចជាអនុសាសន៍ដល់ពួកគេដែរ។ អ្នកថែទាំភាគច្រើន ត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់អង្គការដទៃទៀត ដែលផ្តល់សេវាជម្រកសុវត្ថិភាព។ ពួកគេមួយចំនួនបានជួយយើងពេលដែលយើងអនុវត្តកម្មវិធីថែទាំដោយឪពុកម្តាយធម៌។" កិច្ចសម្ភាសទី ៦

"បុគ្គលិកមួយចំនួនលាលែងពីការងារ បុគ្គលិកមួយចំនួនត្រូវបានដំឡើងតួនាទីឱ្យក្លាយជាភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ច ហើយយើងបានស្នើឱ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនធ្វើជាឪពុកម្តាយធម៌សម្រាប់កុមារ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៤

"បុគ្គលិកមួយចំនួនទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ច ហើយនៅបន្តធ្វើការងារជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៣

គម្រោងពេលវេលាជាក់លាក់

អ្នកតបសម្ភាសស្ទើរតែទាំងអស់ គួសបញ្ជាក់ពីសារសំខាន់នៃការចំណាយពេលចូលរួម និងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ មណ្ឌលថែទាំកុមារជាច្រើន ដែលបានធ្វើការបង្ហែរដោយខ្លួនឯង បានលើកឡើងថា គេត្រូវការពេលចន្លោះពី៣ទៅ៥ឆ្នាំ ដែលក្នុងនោះ គេត្រូវការពេលវេលាភាគច្រើន ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យគ្រប់គ្នាបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះ ដាក់ចេញជាចក្ខុវិស័យគំរូការងារថ្មី ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការងារ ដើម្បីបង្រួបបង្រួមកុមារជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញ។

ពួកគេភាគច្រើន ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការងារកិច្ចការពារកុមារ ហើយបន្ទាប់មករៀបចំផែនការថែទាំសម្រាប់កុមារម្នាក់ៗ ដែលផែនការមួយចំនួនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងចរាចរណ៍ ដោយធ្វើការកំណត់ពីកុមារដែលគេងាយបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងគ្រួសារជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់មកប្តូរទៅជាផ្តល់សេវាផ្អែកតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ អាចជាការថែទាំបណ្តោះអាសន្នដោយឪពុកម្តាយធម៌ ការថែទាំជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយឪពុកម្តាយធម៌ ឬការរស់នៅ៣ក់កណ្តាលឯករាជ្យជាដើម។ អង្គការមួយចំនួនឈប់ទទួលយកកុមារថ្មីទៀតហើយ ប៉ុន្តែរង់ចាំឱ្យកុមារដែលពុំអាចធ្វើសមាហរណកម្មបាន មានអាយុច្រើន ដើម្បីដកចេញពីការថែទាំសិន មុននឹងបិទមណ្ឌលទាំងស្រុង។ ខណៈពេលដែលអង្គការជាច្រើនបារម្ភថាមណ្ឌលថែទាំកុមារ ពុំបានផ្តល់ការតាមដានបន្តឱ្យបានសមស្របដល់កុមារដែលត្រូវបានបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញ អង្គការដទៃទៀត ជាពិសេសអង្គការដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកា គិតថាមណ្ឌលថែទាំកុមារចង់ឧបត្ថម្ភដល់កុមាររហូតដល់ពួកគេក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យសិន។

"មណ្ឌលថែទាំកុមារភាគច្រើនពុំបានអនុវត្តផែនការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារឱ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយ។ ពួកគេចង់មើលថែកុមារពេញមួយជីវិត ដូចជាពួកគេរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យ និងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សិន។" កិច្ចសម្ភាសទី ១០

គិតត្រឡប់ថយក្រោយវិញ នៅពេលដែលធ្វើការសាកសួរ តើពួកគេអាចធ្វើអ្វីផ្សេងខុសពីមុន ប្រសិនបើពួកគេអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនេះ ដូចជាដំណើរការបង្ហែរដោយខ្លួនឯង ឬជួយដល់មណ្ឌលដទៃ

ទៀតក្នុងការបង្ហៃ អ្នកតបសម្ភាសភាគច្រើនបានលើកឡើងថា ពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែម ដើម្បីរៀបចំផែនការ និងចក្ខុវិស័យរួម មុនពេលអនុវត្តដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម។ ដោយសារតែកុមារដែលមកស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារមកពីគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ មណ្ឌលមួយចំនួនជួបការលំបាកក្នុងការធានាឱ្យមានការផ្តល់សេវា និងការគាំទ្រឱ្យបានសមស្របនៅតាមខេត្តដើមកំណើតរបស់កុមារទាំងនោះ ដែលនេះរំលេចឱ្យឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តគោលវិធីដែលត្រូវមានការសម្របសម្រួលជាមួយគ្នា។

"វាគឺជាដំណើរផ្លូវដ៏វែង ហើយនេះ គឺជាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវមាន។" កិច្ចសម្ភាសទី ៥

"យើងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្ត ហើយនៅពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តរួច យើងត្រូវការពេលពី ៣ ទៅ ៤ ខែ ក្នុងការបង្ហៃ គិតចាប់ពីពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាកិបាល ផ្តល់ការអនុម័ត រហូតដល់ការជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកការិយាល័យគាំទ្រ ក៏ដូចជាអ្នកផ្តល់ជំនួយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៦

"រយៈពេល ២ ឆ្នាំ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារធ្វើការបង្ហៃនោះឡើយ។ ការធ្វើសមាហរណកម្ម កុមារត្រូវការពេលវេលា (៣-៦ ខែ)។ ប្រសិនបើយើងធ្វើលឿន យើងមិនអាចបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងឱ្យបានខ្លាំងក្លានោះឡើយ ហើយមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៏ពុំមានថវិការច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ដំណើរការបង្ហៃនេះដែរ ... វាមិនមែនត្រឹមតែជាការប្តេជ្ញាចិត្តរយៈពេល ១-២ ឆ្នាំនោះឡើយ។ យ៉ាងហោចណាស់គួរមានរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៩

"ប្រសិនបើយើងសហការជាដៃគូជាមួយពួកគេ យើងត្រូវការពេល ២ ទៅ ៣ ឆ្នាំ។ យើងផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រធានមណ្ឌលថែទាំកុមារ ហើយបន្ទាប់មកប្រសិនបើពួកគេផ្លាស់ប្តូរមុខដំណែង ឬមានបុគ្គលិកថ្មីណាម្នាក់ចូលមក យើងក៏ចាំបាច់ត្រូវជួយដល់ពួកគេផងដែរ។" កិច្ចសម្ភាសទី ១០

"វាមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាបានលឿននោះឡើយ ហើយយើងក៏មិនអាចបិទច្រកដែលយើងធ្លាប់តែទទួលបានថវិកាគាំទ្រទាំងស្រុងនោះដែរ បើមិនដូច្នោះទេ យើងប្រាកដជាជួបវិបត្តិដែលត្រូវដោះស្រាយជាមិនខាន។" កិច្ចសម្ភាសទី ៣

"ខ្ញុំគិតថាអ្វីៗវាកើតឡើងឆាប់ពេក មានការជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លា ហើយអ្វីៗពិតជាបានកើតមានឡើង។ យើងពុំបានទទួលជំនួយគាំទ្រភ្លាមៗនោះឡើយ។ [មណ្ឌលថែទាំកុមារ] មួយចំនួនបានបិទទ្វារ និងពុំបានទទួលការគាំទ្រអ្វីនោះឡើយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៨

"នរណាដែលនិយាយថាពួកគេអាចធ្វើបានលឿន។ មានន័យថាពួកគេពុំបានធ្វើឱ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយ។ ការងារត្រូវការពេល។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌។" កិច្ចសម្ភាសទី ៥

ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាបន្ទាន់

អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាបន្ទាន់ មានការបារម្ភខ្លាំងជុំវិញសន្ទុះនៃការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងផលប៉ះពាល់មកលើកុមារផ្ទាល់។ ពួកគេគិតថា ចាំបាច់ត្រូវមានការធ្វើការងារជាមួយ

មណ្ឌលថែទាំកុមារ ដើម្បីរៀបចំផែនការជាមុន ជាពិសេស សម្រាប់មណ្ឌលថែទាំកុមារដែលការធ្វើអធិការកិច្ចរកឃើញថាស្ថិតនៅក្រោមបទដ្ឋាននៃការថែទាំកុមារ ប៉ុន្តែអាចមិនបង្កការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់កុមារ។ បុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារផ្តោតលើការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ បន្ទាប់ពីការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារភ្លាមៗ គិតថា និយាយជារួម រដ្ឋាភិបាលនឹងនិយាយដោយឡែក មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀត ដើម្បីឱ្យដំណើរការបង្វែរនេះអាចកើតឡើងដោយរលូន។ ចំណុចនេះក៏ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសមាហរណកម្ម ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ[29] ដែលបង្ហាញថា ការបង្ខំឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារបិទបន្ទាន់ៗអាចបង្កការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់កុមារ ត្បិតពួកគេពុំមានពេលវេលាដើម្បីត្រៀមរៀបចំខ្លួន ឬពិគ្រោះយោបល់ជាមួយកុមារមុនពេលយកកុមារទៅទុកដាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការរកទីកន្លែងឱ្យបានសមស្របសម្រាប់ទុកដាក់កុមារផងដែរ។ ខណៈពេលដែលការបង្ខំបិទទ្វារមណ្ឌលថែទាំកុមារភ្លាមៗ ពេលខ្លះ ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើ ដោយសារតែកុមារដែលទទួលបានការថែទាំពីមណ្ឌលទាំងនោះ ជួបប្រទះនឹងហានិភ័យចំពោះមុខ ជារឿយៗការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារដោយបង្ខំ តែមិនបន្ទាន់ភ្លាមៗ មានភាពសមស្របជាង ដើម្បីទុកពេលឱ្យគេអាចធ្វើផែនការ និងធានាឱ្យមានការធ្វើបង្វែរឱ្យបានកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កុមារដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនោះ។

"មណ្ឌលថែទាំកុមារ មួយចំនួនមិនមានធនធានទៀត និងចាំបាច់ត្រូវបិទមណ្ឌលជាបន្ទាន់ និងពុំមានថវិកាបម្រុងសម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្មនោះឡើយ។" កិច្ចសម្ភាសទី ២

"វាខុសគ្នាពីការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ ការបង្វែរមណ្ឌលថែទាំកុមារ ធ្វើបានល្អជាង ព្រោះថាគេមានពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលល្អសម្រាប់កុមារ។" កិច្ចសម្ភាសទី ៧

"សម្រាប់ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារបន្ទាន់ [មាន] គណៈកម្មាធិការ និងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសដែលត្រូវអនុវត្តតាមដំណើការនេះ ហើយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកុមារ កម្មវិធីជាក់លាក់សម្រាប់ធ្វើការបង្វែរ អ្នកដែលអាចជួយដល់ការងារនេះបាន។ យើងធ្វើការងារជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។" កិច្ចសម្ភាសទី ១០

---

[29] សេចក្តីណែនាំស្តីពីអន្តរកាល និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ពុំបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។

អនុសាសន៍

បើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៧ ដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា "ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រពៃណីប្រើប្រាស់យន្តការតាមសហគមន៍ ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ។ ការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័ស និងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៃចំនួនកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបង្កក្តីបារម្ភចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកធ្វើការកិច្ចការពារកុមារ។"[30] អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលដៅធ្វើសមាហរណកម្មកុមារចំនួន៣០%ចេញមណ្ឌលថែទាំកុមារ ត្រឡប់ទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។[31] ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជាបានថយចុះ៤៣% ហើយចំនួនកុមារដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនេះថយចុះ ៥៩%។[32]

លើសពីនេះទៅទៀត ជំងឺកូវីដ១៩ បានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាសកលមកលើអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមមណ្ឌលថែទាំនានាផងដែរ។ ការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩ បានឱ្យដឹងថា អ្នកឆ្លើយតបចំនួន ៩០% គិតថាជំងឺកូវីដ១៩ បានជំរុញឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំង និងផ្តល់ជាឱកាសឱ្យគេធ្វើការពិចារណា និងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរនានា។ ជំងឺកូវីដ១៩ បង្កផលប៉ះពាល់ទូទាំងសកលលោក ដល់អ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងបរិបទនៃការថែទាំកុមារតាមមណ្ឌល។ ខណៈពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនេះ បង្កមហន្តរាយជាច្រើន វាក៏បានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរ។ ក្នុងនោះអត្ថប្រយោជន៍មួយក្នុងចំណោមអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន គឺឱកាសក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ ផលវិបាកនៃការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារជាបន្ទាន់ ឬការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារភ្លាមៗ និងការពឹងអាស្រ័យលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងឬ ភ្ជៀវដើម្បីរៃអង្គាសថវិកា។ ទោះបីជាអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសសុទ្ធតែមានទស្សន និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នាកោះដោយ នេះជាមូលដ្ឋានរួម ដែលអាចផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់រៀបចំការអនុវត្តនាពេលអនាគត។[33]

មានការលើកឡើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថា ច្បាប់និងតួនាទីការកិច្ចដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិមានសារសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកំណត់ពីតម្រូវការនៃការបង្ការ និងការជំរុញសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ ខណៈពេលដែលក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលក្រសួងចង់បាន តាមរយៈការដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពជាតិ ចាំបាច់ត្រូវមានការបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដូចជា៖

---

30 *ការកំណត់ទីតាំងនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង ២៤ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។* រៀបចំដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៧)

31 *ផែនការសកម្មភាព ដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែទាំកុមារ ជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅបញ្ជូនកុមារ ៣០% ត្រឡប់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់ពួកគេវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ២០១៦-២០១៨។ (បន្តអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២០)* របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (២០១៧)។

32 *របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការថែទាំកុមារ។* របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (២០២០)។

33 Nhep, R. van Doore, K. (April 2021). *Impact of COVID-19 on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ គ.ក.ន.ក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្ម កុមារ ជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលពុំមានអង្គការដៃគូ ដើម្បីបំពេញតួនាទីនេះបាន។ ខណៈពេលដែលតួនាទីទាំងនេះ ត្រូវបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្ម ការបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ការផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាព ធនធាន និងការគាំទ្របច្ចេកទេសជាបន្តបន្ទាប់ មានសារសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងការអនុវត្តនេះ។ នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរស្ថាប័ន រវាងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូ និងមណ្ឌលថែទាំកុមារ បានជួយនាំឱ្យមានការរៀបចំផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ កំណត់ពីការទទួលខុសត្រូវ និងចក្ខុវិស័យរួមដើម្បីជួយដល់ដំណើរការបង្វែរនេះ។ លើសពីនេះ មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និង គ.ក.ន.ក ត្រូវការថវិកាគាំទ្រឱ្យបានសមស្រប ដើម្បីបំពេញតួនាទីដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យ ក្នុងការជួយដល់ការបង្វែមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ។

អ្នកតបសម្ភាសជាច្រើន បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈម ពេលដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើការងារជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលពុំបានចុះបញ្ជី និងមានឥទ្ធិពលលើមណ្ឌលទាំងនេះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងដាក់ពិន័យលើមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលដំណើរការដោយខុសច្បាប់ ប៉ុន្តែដោយសារតែលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងនេះ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តមួយរយៈពេលទៅហើយនោះ ឥឡូវនេះ ចាំបាច់ត្រូវមានការពង្រឹងការអនុវត្តឱ្យកាន់តែតឹងរ៉ឹងបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាឱ្យមានការអនុវត្តតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងនេះ។

បន្ថែមលើការបំពេញតួនាទីការកិច្ច មណ្ឌលថែទាំកុមារ ត្រូវការការគាំទ្រដល់ការរៀនសូត្រពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅកម្ពុជា ដែលបានធ្វើការបង្វែរប្រកបដោយជោគជ័យកន្លងមក។ ការផ្តោះប្តូរបទពិសោធន៍ និងការចែករំលែកឧបករណ៍គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីនានាអាចបំពេញបន្ថែមលើក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និងជួយកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាច និងភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់នាយក និងបុគ្គលិកមណ្ឌលថែទាំកុមារមាននៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្វែរនេះ។

ការធ្វើបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារអាចត្រូវការពេលវេលា ហើយការមានពេលរៀបចំផែនការបង្វែរ និងដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យរួម គឺជាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិក អ្នកផ្តល់ការថែទាំរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតនោះ គឺសម្រាប់កុមារដែលស្ថិតក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងគាំទ្រដល់ដំណើរការបង្វែរ ចាំបាច់ត្រូវទុកពេលវេលា និងផ្តល់ធនធានមនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ (យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវផ្តល់ថវិការយៈពេល ៣ ឆ្នាំ) ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការនេះ។ នេះរួមមានការផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រដល់ គ.ក.ន.ក និងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិដទៃទៀត ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

គួរមានការរៀបចំផែនការ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារភ្លាមៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើកុមារ។ ខណៈពេលដែលពេលខ្លះទាមទារឱ្យមានការបង្ខំបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារភ្លាមៗ ប្រសិនបើមានហានិភ័យចំពោះមុខលើកុមារ ដែលកំពុងទទួលបានការថែទាំនៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនោះ ជារឿយៗការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារតាមសម្រួល មានលក្ខណៈសមស្របជាង ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យគេអាចរៀបចំ

ផែនការ និងធានាការបង្វែរមានភាពកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កុមារដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនោះ។ អ្នកតបសម្ភាសគិតថា មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ចាំបាច់ត្រូវបំពេញតួនាទីបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយដល់ដំណើរការនេះ។ ខណៈពេលដែលការស្វែងរកមតិគាំទ្រ និងការរៀបចំយុទ្ធនាការបានជួយបង្កើនការយល់ដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គេត្រូវការទិន្នន័យបន្ថែមទៀត ដើម្បីកំណត់ឱ្យដឹងថាតើសមាជិកសហគមន៍បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនយល់ឃើញច្រើនកម្រិតណា និងថាតើយន្តការអ្វីខ្លះដែលមានប្រយោជន៍បំផុត ដើម្បីជួយសម្រួលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញបែបនេះ។ ទាំងការសម្ភាស ទាំងការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធសុទ្ធតែបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា គេចាំបាច់ត្រូវរៀបចំសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗគ្នា អាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹង និងកត្តាដែលលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងសមាជិកសហគមន៍។ ចាំបាច់ត្រូវមានការអនុវត្តការងារបន្ថែមទៀត ដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់គ.ក.ន.ក ព្រមទាំងសហគមន៍នៅតំបន់ជនបទ ដែលមិនសូវទទួលបានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ។ ការធ្វើបែបនេះអាចជួយទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការយកកុមារទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារពីដំបូង និងគាំទ្រដល់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារប្រកបដោយជោគជ័យ។

ដោយសារតែអ្នកផ្តល់ជំនួយមានឥទ្ធិពលលើជោគជ័យនៃការធ្វើបង្វែរ និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ ការចូលយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការចូលរួមសហការរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ ដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូឱ្យកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងក្រុមតស៊ូមតិនៅតាមប្រទេសផ្តល់ជំនួយ និងចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមស្រដៀងគ្នានេះ ដើម្បីបញ្ឈប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រា ដូចជាយុទ្ធនាការទេសចរណ៍សុវត្ថិភាពកុមាររបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ជាដើម។ អ្នកផ្តល់ជំនួយជាច្រើនបានធ្វើបង្វែរប្រកបដោយជោគជ័យពីការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់កុមារម្នាក់ៗ ទៅជាអភិក្រមនៃការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ជួយដល់កុមារនៅក្នុងសហគមន៍វិញ។ គេអាចឈ្វេងយល់បន្ថែមទៀតអំពីកត្តាដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកផ្តល់ជំនួយ ប្តូរទម្រង់ពីការជួយដល់កុមារម្នាក់ ទៅជាការជួយដល់សហគមន៍វិញ។

ការធ្វើសមាហរណកម្មប្រកបដោយជោគជ័យ ត្រូវឆ្លើយតបចំពោះមូលហេតុដែលនាំឱ្យគេយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារពីដំបូង។ ការបង្កើនការវិនិយោគលើសេវានៅតាមសហគមន៍ និងការផ្តល់ការគាំទ្រនូវតម្រូវការចាំបាច់ដល់គ្រួសារដែលងាយរងហានីភ័យ ពិតជាអាចគាំទ្រដល់ការការពារកុមារឱ្យរស់ជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេ និងកាត់បន្ថយការបំបែកកុមារចេញពីក្រុមគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់។

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ៈ សំណួរសម្រាប់សម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

១. តើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រអ្វីខ្លះ ដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារ ដើម្បីធ្វើបង្វែរ និង/ឬបិទទ្វារ?

២. តើមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយរបៀបណា?
- តើមាននរណាម្នាក់មកពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ មកទាក់ទងអ្នក/អង្គការរបស់អ្នកដែរឬទេ តើមណ្ឌលទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាដែរឬទេ ឬតើអ្នកបានទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពួកគេ?
- តើមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងនេះ ស្ថិតនៅដំណាក់កាលណានៅពេលដែលអ្នកទាក់ទងទៅកាន់ពួកគេ ឬនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យធ្វើការជាមួយនឹងមណ្ឌលថែទាំកុមារនេះ? (ឧទាហរណ៍ អប់រំផ្សព្វផ្សាយ/រៀនសូត្រ, ដំណាក់កាលរៀបចំផែនការ និងត្រៀមរៀបចំខ្លួន, ដំណាក់កាលអនុវត្ត)

៣. តើអ្នកអាចជួយដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារបានប៉ុន្មាន?
- ក្នុងចំណោមមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងនេះ តើមានមណ្ឌលថែទាំកុមារប៉ុន្មាន ដែលអ្នកបានជួយរហូតដល់មណ្ឌលទាំងនេះអាចបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាថែទាំដល់កុមារទៀត? តើមណ្ឌលទាំងនេះបានធ្វើបង្វែរ ឬបិទទ្វារ?
- តើមានមណ្ឌលថែទាំកុមារប៉ុន្មានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនេះ តើពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណា?

៤. តើអ្នកធ្វើការងារជាមួយនរណានៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនេះ និងធ្វើការងារអ្វីខ្លះ?
- ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឡប់ក្រោយវិញ តើមានតួអង្គពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតណា ដែលអ្នកចង់សហការជាមួយ ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានសហការជាមួយដែរឬទេ?

៥. តើអ្នកគិតថាមណ្ឌលថែទាំកុមារត្រូវការការគាំទ្រអ្វីខ្លះ សម្រាប់ការធ្វើបង្វែរ និងការបិទទ្វារ ហើយតើបច្ចុប្បន្ននេះ មានការផ្តល់ការគាំទ្រអ្វីខ្លះ?

៦. តើអ្នកដឹងថាតើមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែលអ្នកកំពុងធ្វើការងារជាមួយបានថវិកាគាំទ្រពីប្រភពណាដែរឬទេ?
- ប្រសិនបើដឹង ពីប្រភពណា?

៧. តើអ្នកដឹងថានរណាជាអ្នកបង្កើតមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលអ្នកកំពុងធ្វើការងារជាមួយដែរឬទេ និងហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតមណ្ឌលថែទាំកុមារនេះ?

៨. តើអ្នកគិតថាមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងអស់អាច ឬគួរធ្វើបង្វែរទាំងស្រុង ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទៅផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

៩. តើអង្គការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះ ដើម្បីអនុវត្តជំហានផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការបង្វែរនេះ?

១០. តើដំណើរការបង្វែរជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារផ្សេងទៀត ត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណា?

១១. បើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នក តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារ អាចបោះជំហានទៅមុខក្នុងដំណើរការបង្វែរនេះ?
- និងតើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យមណ្ឌលថែទាំកុមារជួបការលំបាកក្នុងការបោះជំហានទៅមួយដំណាក់កាលទៀត?

១២. តើអ្នកធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកបារម្ភពីសុខមាលភាពរបស់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌល ឬបារម្ភពីកត្តាដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការធ្វើសកម្មភាពរបស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនេះដែរឬទេ?
- ប្រសិនបើមានការបារម្ភបែបនេះ តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះ? ប្រសិនបើពុំមានការបារម្ភនោះទេ តើអ្នកនឹងគិតថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះ?

១៣. តើដំណើរការនេះស្រដៀងគ្នា ឬខុសគ្នានឹងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារភ្លាមៗ?

១៤. សូមឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញលើដំណើរការនេះ៖
- តើអ្នកនឹងផ្តល់ដំបូន្មានអ្វីខ្លះ ដល់អ្នកដទៃទៀតដែលកំពុងជួយដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងការធ្វើបង្វែរ?
- សូមគិតពីឧទាហរណ៍ដែលទទួលបានជោគជ័យ តើអ្នកគិតថាអ្វីខ្លះ ដែលនាំឱ្យមានការសម្រេចជោគជ័យបែបនេះ?
- តើអ្វីទៅដែលជាផ្នែកដែលពិបាកជាងគេ នៅពេលជួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ ធ្វើបង្វែរ?
- តើអ្នកគិតថាមានដំបូន្មាន ឧបករណ៍ ឬការណែនាំបន្ថែមអ្វីផ្សេងទៀត ដែលនឹងជួយអ្នក ឬអង្គការដទៃទៀតនៅពេលដែលអ្នកផ្តល់ការគាំទ្រដល់ដំណើការបង្វែរដែរឬទេ?
- តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការងាររបស់អ្នកដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

FAMILY CARE FIRST | REACT

ក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល

បណ្តាញដៃគូ REACT

3PC
Together, building stronger child protection systems

ដៃគូ

អ្នកផ្តល់ជំនួយ

Follow us

www.fcf-react.org

Family Care First - REACT

FAMILY CARE FIRST | REACT

www.familycarefirst.org

Lessons Learned in Residential Care Institution Transition and Closure

USAID

GHR FOUNDATION

Save the Children 100 YEARS

unicef

Acknowledgements

We would like to thank the Royal Government of Cambodia and UNICEF for participating in the study as well as all the organizations that took part in the interviews: Cambodia Children's Trust, Children's Futures International, Friends International, Hagar International, Holt, Komar Rikereay, Mith Samlanh, M'lup Russey, This Life Cambodia, and UNICEF for offering their experiences and expertise. We would also like to thank the Better Care Network for their guidance.

Rebecca Smith

November 2021

DISCLAIMER

This publication was made possible by the generous support of the European Union (EU) and the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsible of the lead consultant and Save the Children and do not reflect the views of the EU or USAID.

Contents

Lessons Learned in Residential Care Institution Transition and Closure 1
Acknowledgements 2
DISCLAIMER 3
Contents 4
Abbreviations 5
Executive Summary 6
Background 9
Objective of Study 11
Methodology 12
Research Questions 12
Ethical Considerations 14
Limitations 14
Findings 15
Partnership and Coordination 16
Changing mindsets and creating shared vision 19
Community support 23
Role of the Donors 24
Considerations for RCI Staff 26
Realistic timeframes 27
Emergency Closure 28
Recommendations 30
ANNEXES 33
Annex I: Key Informant Interview Questions 33

Abbreviations

CCWC	Commune Committee for Women and Children
DoSVY	Department of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation
FCF	Family Care First
KII	Key Informant Interview
MoI	Ministry of Interior
MoSVY	Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation
MoU	Memorandum of Understanding
NGO	Non-Government Organisation
NISA	National Institute for Social Affairs
RCI	Residential Care Institution
REACT	Responsive and Effective Child Welfare System Transformation
SBCC	Social Behavior Change Communication
SOP	Standard Operating Procedure
UNICEF	United Nations Children's Fund
USAID	United States Agency for International Development
WCCC	Women and Children Consultative Committees
3PC	Partnership Program for the Protection of Children

Executive Summary

"An RCI is a centralized hub for children's needs, so it is about decentralizing those support services back into the community" KII3

In 2017 the Royal Government of Cambodia raised concerns about the rapid increase in the number of institutionalized children in Cambodia[1] and as a result set an ambitious target of safely reintegrating 30 percent of children in residential care institutions (RCIs) into families.[2] By 2019, there has been a 43 percent reduction in the number of RCIs in Cambodia and a 59 percent reduction in the number of children in these facilities.[3]

In addition to this progress, COVID-19 caused global ramifications for anyone working in residential care settings. While there are many devastating consequences of the pandemic, some of the benefits have been the opportunity to reflect on the use of RCIs, the consequences of emergency closure, the importance of follow up in reintegration, and the reliance of international volunteers and visitors for the fundraising model of many RCIs. Successful transition of RCIs consists of a number of interrelated key elements that need to be considered at the same time including: the reasons why children are entering residential care, the laws and policies in place, the motivations and funding models of the RCI management and donors, the availability of services within the community including family-based alternative care services, the individual needs of the children in the RCI, and the ability to support reintegration efforts.

Those interviewed highlighted key themes that support successful transition and closure as well as identifying areas that need to be strengthened.

These include:

- *A strong national framework:* The Royal Government of Cambodia has created a strong national framework through their National Plan of Action which has placed pressure on RCIs to transition and has supported successful reintegration. However more work needs to be done to further standardize child protection responses throughout the country. The Child Protection Law which is currently in development will help support this standardization. The Guidelines on Transition and Closure of

[1] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2017). *Mapping of residential care facilities in the capital and 24 provinces of the Kingdom of Cambodia.* MoSVY, Kingdom of Cambodia.
[2] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2017). *Action Plan for Improving Child Care with a target of safely returning 30 percent of children to their families 2016-2018.* (extended to 2020)
[3] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2020). *Report on Results of the Implementation of the Action Plan for Improving Childcare*.

RCIs which are also currently in draft will also further support the interagency agreements between DoSVY, the RCIs, and civil society organizations which will help to outline the shared vision and plan to achieve transition.

- *Clear roles and responsibilities amongst actors:* Further clarity is needed on the roles and responsibilities at the district level to support transition and reintegration. Investment in DoSVY and the CCWCs would help to further empower them to deliver their mandate.

- *Support on the "how"*: RCI directors and management should continue to be supported through learning exchanges and the sharing of tools, policies, and procedures to show how transition can happen safely and contribute to a shared vision.

- *Greater awareness and targeting of messaging:* While many actors in Cambodia have started raising awareness on the importance of family-based care and the harms of institutional care, more needs to be done to target rural communities and donors outside of Cambodia. RCI staff as well as family members and communities have different motivations for their continued support to RCIs. These motivations and fears need to be better understood to target messaging more specifically. More could be learned in applying SBCC techniques to this specific target group.

- *Advocacy and engagement with donors:* Given how influential the donors can be in whether or not transition and closure is successful, the Royal Government of Cambodia and civil society should consider incorporating a donor engagement strategy to form stronger partnerships with advocacy groups in donor countries and join similar initiatives to stop orphanage volunteering such as the Ministry of Tourism's child safe tourism campaign. Lessons could be taken on how donors have moved away from individual child sponsorship programs of specific children towards community-based sponsorship in other contexts.

- *Community-based services:* Effective transition requires addressing the reasons that children are placed in residential care in the first place. Greater investment is needed in community-based services and outreach to at-risk families, particularly following the economic impact that COVID-19 has had on families.

- *Realistic timeframes:* Transition and closure can take time and having the time to plan the transition and develop a shared vision is beneficial to the staff, caregivers and more importantly to the children in their care. Government, donors and civil society actors that are supporting the transition process need to allow for sufficient time and both human and financial resources to support this process.

- *Emergency closure:* Emergency closure can be traumatic to children and very challenging for all actors involved. Even if forced closure is necessary, it should, to the extent possible, be planned and sequenced as long as there is not an immediate risk to children. DoSVY should play a greater role in facilitating emergency closure given the lack of mandate civil society has in this process.

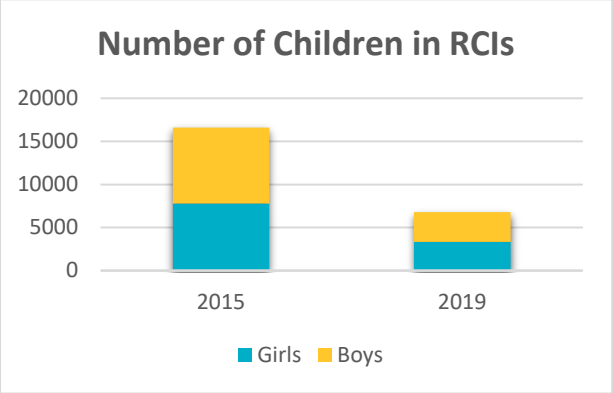
Background

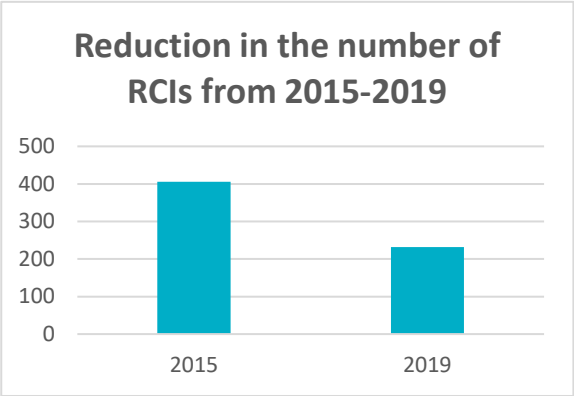
According to a 2017 report by the Royal Government of Cambodia, "the rapid and uncontrolled increase in the number of institutionalized children in Cambodia, traditionally a country with community-based mechanisms for the alternative care of children, has long raised the concerns of the government and child protection workers."[4] Between 2005 and 2010 there was a 75 percent increase in the number of residential care institutions (RCIs) operating in Cambodia.[5]

According to a 2015 mapping by the Royal Government of Cambodia, there were 639 residential care facilities (406 classified as RCIs) with a total of 26,187 children under the age of 18 living in them, and 16,579 children living in the 406 RCIs.[6] The distribution of RCIs across Cambodia is highly uneven with the majority located in areas frequented by tourists and promoted by a phenomenon commonly known as voluntourism. To address these issues in 2016, the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSVY) launched an ambitious action plan to reduce the number of children living in RCIs across five key provinces and introduced a moratorium on the registration of new childcare institutions. The Royal Government of Cambodia has created a legally enabling environment with policies, legislation, and targets for the reduction of children in RCIs.[7] This has formed a strong foundation for NGOs and others to build upon and is *closely aligned* with the Government of Cambodia's Action Plan and priorities around care reform.[8] The three-year action plan from 2016-2018 was extended to 2020.[9] According to a review of the action plan in 2019, the number of RCIs had decreased by 43 percent and the number living in them had decreased by 59 percent.

---

[4] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2017). *Mapping of residential care facilities in the capital and 24 provinces of the Kingdom of Cambodia*. MoSVY, Kingdom of Cambodia.
[5] Better Care Network. (2020). Cambodia Country Care Profile. The Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation and the Better Care Network.
[6] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2017). *Mapping of residential care facilities in the capital and 24 provinces of the Kingdom of Cambodia*. MoSVY, Kingdom of Cambodia.
[7] For a list of relevant laws and policies of reform, please see pages 26-33 Better Care Network. (2020). Cambodia Country Care Profile. The Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation and the Better Care Network.
[8] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2017). *Action Plan for Improving Child Care with a target of safely returning 30 percent of children to their families 2016-2018.* (extended to 2020)
[9] Ibid





Family Care First (FCF), coordinated by Save the Children, was established in 2015 with funding from USAID to bring together organisations using a collaborative approach to decrease the number of children in residential care institutions. In 2019 the European Union provided complimentary funding with the addition of the Responsive and Effective Child Welfare System Transformation (REACT) project to ensure that children's rights and child participation continued to be a vital component of care reform. FCF | REACT is now a network of approximately 60 member organisations, some of whom are funded, working to prevent children from being separated from their families and increase the number of children that are safely and successfully integrated into family-based care. This is done through focusing on four key result areas:

1. National government is supported to roll out child protection legislative and policy frameworks with monitoring systems.
2. Sub-national government authorities in five target provinces are supported to effectively monitor and regulate the quality of protection services and residential care institutions.
3. Girls and boys who have been deprived of parental care and/or separated from their families are provided with appropriate quality alternative care and/or reintegration.
4. Effective measures to prevent family separation are utilized in five target provinces.

Through this effort, according to the Child Tracking Tool, 41 percent of children in the priority provinces who have been reintegrated were either supported by the Government or 3PC and FCF | REACT partners.[10]

[10] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2020). *Report on Results of the Implementation of the Action Plan for Improving Childcare*.

Objective of Study

The objective of this study is to document lessons learned from FCF | REACT members, as well as the literature from others working on transition globally, to create evidence-based recommendations to inform future transitions and closure at scale. This review will be shared broadly with MoSVY, DoSVY, UNICEF, and FCF | REACT members and other interested stakeholders as the Royal Government of Cambodia finalises their Guidelines on Reintegration, Transforming and Closure of RCIs.

Methodology

The identification and documentation of lessons learned for this report was done through two primary methods:

- Desk review of existing documentation/ studies related to RCI transition and closure. This prioritised work done by FCF | REACT members and in Cambodia, but other relevant literature was included as well
- Key informant interviews (KIIs) with key stakeholders involved in, or who have important insights on, RCI transition and closure.

Research Questions

- Under what conditions has transitioning RCIs in Cambodia been the most successful?
    - Under what conditions has closing RCIs in Cambodia been successful (how is this different or similar to transitioning?)
- What are the main steps, stages and process and stakeholders involved in transitioning and/or closing RCIs?
- What approaches are most useful and why?
- What challenges are we facing and how can we best address these?
- What conditions and approaches are different (or the same) for transition versus closure?
- What, if any, additional tools, guidance may be needed?
- How does the experience of transition/closure in Cambodia compare to other countries?

Data Collection and Analysis

Desk Review

Desk review documents were collected in two ways:

1. Cambodian documents identified by the FCF | REACT team based on their knowledge of documentation conducted as well as a request to the larger network for any relevant documents they may be aware of.

2. Global documents, primarily based on a search of the Better Care Network collection of materials and advice from the conveners of the Global Collaborative Platform Transitioning residential care working group, a search for published articles and abstracts, the CPC Learning Network, and the Save the Children Resource Centre. A google search of "transitioning residential care" was also be conducted to ensure nothing was missed.

Documents for the review were included based on their relevance to the topic (i.e. the focus on transition/closure of RCIs) rather than a broader review of general information related to residential care. The desk review was conducted in English and limited to grey literature or practitioner accounts. Particular attention was made to examples gathered from Cambodia and Southeast Asia. In total, 25 documents were reviewed as part of this study.

The findings from this desk review helped inform the KII questions (see Annex 1).

Key Informant Interviews

KIIs were held with key stakeholders involved in – or who would have important insights on – RCI transition and closure. Stakeholders to be included in the KIIs were identified by FCF | REACT based on known involvement in RCI transition or closure. Stakeholders were approached by the FCF | REACT team with the objective of this lessons learned documentation and requested to participate. They were then asked to identify staff member(s) who were best placed to be interviewed and whether they preferred to be interviewed in English or have Khmer translation for the interview.

A formal letter of request for an interview was sent to MoSVY and a representative from the Royal Government of Cambodia was also interviewed as part of this process.

In total, 12 key informant interviews with 19 stakeholders (16 Cambodians/3 expatriates; 47% female/53% male) from 11 organisations were conducted over September-October 2021. Those participating were from the Royal Government of Cambodia, the Better Care Network, Cambodia Children's Trust, Children's Futures International, Friends International, Hagar International, Holt, Komar Rikereay, Mith Samlanh, M'lup Russey, This Life Cambodia and UNICEF.

Analysis

During each interview in-depth verbatim notes were taken, and the interviews were recorded with the consent of those being interviewed. Each interview was conducted separately for each organization with the exception of M'lup Russey and Friends International which were interviewed together with the support of Khmer translation for an hour and a half rather than the one hour allocated to other interviews. The notes were printed out and coded based on key themes that emerged. The researcher then listened to all of interviews again to see if any areas were missing, if any codes needed to be added, and to verify the accuracy of any quotes included. The desk review informed the initial key questions and then each of the documents was reviewed again against the key themes identified through the key informant interviews. These key themes were then used as the headings for the report.

Ethical Considerations

All interviews were confidential unless there was something a specific a stakeholder wanted to have included, however none of those interviewed requested this. The researcher gained verbal consent for each of the interviews as well as consent to record the session. While the interviews were recorded for the purposes of notetaking, they were destroyed when the report was finalised.

Questions were framed around work with RCIs rather than individual children, but if any child safeguarding concerns had arisen, these would have been shared with the safeguarding focal point at Save the Children International for follow up. While this was in place, no safeguarding concerns were shared as part of the interview process. Children were not interviewed as part of this study.

Limitations

This review is specifically focused on the experiences of stakeholders involved in supporting the transition and closure of RCIs and is therefore limited to the perspectives of those interviewed. However, some information from the desk review, including case studies developed by the Better Care Network and findings from focus group discussions held with RCI staff as part of the co-design process for FCF in early 2021, have also captured some perceptions from RCI staff and directors. This study also does not specifically look into implications of COVID-19 on RCI transition and closure, but it is referenced as many of those interviewed touch on these issues, as well as it also being highlighted in the study on the impact of COVID-19 on privately run residential care institutions which was included in the

desk review.[11] While the desk review did highlight the most relevant documents, there have not been many articles written on this subject. With only 25 items, it is highly probable that some lessons learned have just not been published, documented, or shared. As part of this process, a representative from MoSVY was interviewed, however no members of DoSVY or the CCWC were interviewed, and it is very possible that they will have different perspectives based on their experience.

Findings

The Royal Government of Cambodia has made significant progress in supporting the transition and closure of RCIs throughout the country especially through the National Action plan and subsequent enabling legislative and policy environment.

"When the policy came out and they realized that the Government was serious about it… many RCIs were motived to change their approach." KII8

[11] Nhep, R. van Doore, K. (April 2021). *Impact of COVID-19 on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School.

"The Government plan is very important, especially from the Ministry level, the Ministry is promoting this work and now we have the department here to reintegrate children. Sooner or later there will be no more RCIs." KII9

However, successful transition consists of a number of interrelated key elements that need to be consider at the same time including: the reasons why children are entering residential care, the laws and policies in place, the motivations and funding of the RCI management and donors, the individual needs of the children in the RCI, the availability of services within the community including family-based alternative care services, and the ability to support reintegration efforts. As highlighted by Faith to Action:

"*A transition is not the mere closing of residential care. It is a transformation into a new way of conducting business, providing care, and interacting with the community."*[12]

While the majority of FCF | REACT members interviewed are supporting a small number (1-5) of RCIs to transition or close, several have supported more with one having supported 50. Through the literature review, and interviews with key stakeholders, a number of themes emerged on what supports successful transition and closure of RCIs and some of the barriers to successful transition. All of those interviewed discussed at length the importance of working in partnership, specifically with the local and national Government and the role of the donors in supporting or undermining transition. Many highlighted the challenges in changing the mindsets of those involved at various levels, considerations for RCI staff, having realistic timeframes, the challenges and considerations for emergency closure and the importance of support from the community. In the next section each of these areas will be discussed in more depth.

Partnership and Coordination

All those interviewed stressed the importance of working in partnership with the national and local Government (MoSVY/DoSVY), as well as the RCI managers and directors and the civil society organisations that provide various levels of support. Some of those were able to formalize this partnership through interagency agreements between the Government, civil society, and RCI or MOUs with the parties involved. They recommended that these

[12] Faith to Action Initiative. 2016. Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual. Page 16.

agreements clearly outline the roles and responsibilities of each actor and be accompanied by a shared workplan. Some formed a steering group made up of the RCI management, NGO supporting the process and DoSVY while others suggested in retrospect that a steering committee would have been helpful to oversee and drive the process forward. The majority of those interviewed stressed how Government involvement at both the national and district levels have been fundamental in convincing the RCIs to transition.

Many of those interviewed specifically noted that the National Action Plan and commitment to a 30 percent reduction of children in RCIs, helped to motivate RCIs to start the transition process. This was further supported as MoSVY started their inspection process. However, some also highlighted that the ambitious target made it hard to keep up with the demand and some RCI directors struggled to get the support they needed to safely transition.

"To get this task done successfully, we need to work with local governments like the Commune Committees." KII7

"Based on this operational plan, the working group for leading and co-leading, Excellency Chairs for the Women's Commune Council (WCC) based on the action plan… have an RCI meeting and make a plan together, which NGOs want to integrate together, we make a plan together and we provide the technical support to the RCI which want to cooperate with DoSVY.. some cases are managed by the Government, other cases managed by NGOs." KII12

"I think things happened too quickly here. There was a big push, and it was happening. We didn't have all the help immediately, even these guidelines, transition and closure guidelines. We didn't all come together with a strong roadmap at the very beginning that would have helped… some closed and didn't have support." KII8

The literature backs up the need for engaging multiple stakeholders to support successful transition. This includes the Government, but also the children and families, the donors, the staff, and the service providers.[13] Coordination is particularly important given the number of actors within Cambodia responsible for child welfare and child protection with MoSVY having the primary responsibility, but with services overseen and delivered by the District and Commune Administrations which are overseen by the Ministry of Interior (MoI).[14] A study of the impact of COVID-19 on residential care institutions found that 76 percent of RCIs in the

[13] Faith to Action Initiative. (2016). Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual.
[14] Better Care Network. (2020). Cambodia Country Care Profile. The Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation and the Better Care Network.

study experienced a decrease in the number of children in their care with the greatest determinant of reintegration throughout COVID-19 based on pre-existing government gatekeeping mechanisms in place.[15]

Some of the challenges faced initially with reintegration were based on the lack of a standard approach for reintegration and insufficient funds for subnational actors to carry out their roles. MoSVY, with the support of UNICEF and civil society actors, is currently drafting an overarching child protection law supported by Standard Operating Procedures (SOP) for Child Protection. As of November 2021, there were a series of consultative workshops with relevant ministries following a series of sub-national consultations on the child protection law. This law, along with the Guidelines on Reintegration, Transforming and Closure of RCIs will help to further clarify the roles and responsibilities of the various actors in transitioning RCIs, reintegrating children in their care, and investing in community-based services and support. The Guidelines for Reintegration and Reunification of Children from RCIs currently being drafted by MoSVY is intended to support DoSVY and partners to more consistently approach reintegration. It should also support with the establishment of Provincial Reintegration Teams in key provinces to further help to standardize approaches.[16]

In addition to SOPs, MOUs, and interagency agreements, those interviewed also spoke about the practical activities that can support partnership. They mentioned importance of learning exchanges from those that have done it, study visits, and establishing support groups with RCIs that are going through the process to learn from one another.

Coordination and communication were also highlighted as a key component of successful reintegration in terms of case management, family tracing and reunification, but also maintaining good practices of monitoring, documentation, and evaluation.[17]

"We are not doing it alone. We work with the village support groups and we have RCIs, MoSVY and the community people together." KII10

"We believe this is all about working in partnership with the RCI. We're giving them our policies and systems and process and they are adapting them to their needs…. The partnership is critical because you have to have someone partnering with you that is confident in the work." KII15

---

[15] Nhep, R. van Doore, K. (April 2021). *Impact of COVID-19 on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School.
[16] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. (2018). Guideline for the Establishment of Provincial Reintegration Teams (Kandal, Phnom Penh, Preah Sihanouk, Battambang and Siem Reap).
[17] Wedge, J. 2012. Reaching for Home: The Interagency Group on Reintegration. Global Learning on Family Reintegration in Low and lower-middle income Countries. GHR Foundation.

"We do training, study tour and exchange perspectives from those that have already transitioned, to see the way those that transitioned did it and to share their process and understanding the challenges… It is very helpful. We are not doing it alone, we work with the village support group and we have the RCI, MoSVY, and community people together." KII10

"In the past when we transferred a case, we had to travel, but now between MoSVY and DoSVY, we can transfer the documents through the online system. This can help" KII12

"Some of the children are from far provinces, not only neighbouring provinces so this requires a lot of efforts of the staff." KII9

Changing mindsets and creating shared vision

The concept of changing mindsets and perceptions of RCIs came up in many ways relating to the RCI staff members, the Commune Committees for Women and Children (CCWC), and the children themselves. This is the aspect of transition that interviewees stated takes the most time. Most of the civil society partners started to engage the RCIs through information sessions where they discussed the problems associated with residential care and often showcased other organisations that had transitioned, usually together with MoSVY or DoSVY representatives. Some worked directly with RCIs that they were already engaged with or had worked with in the past. Some organisations shared studies which highlighted the harm of institutional care, while others shared case studies and personal stories of children or care leavers who transitioned out of residential care, while others focused on the business model and made an economic argument for change. This reflects themes from the literature review, especially several case studies,[18] which show the different motivations of RCI directors and the different viewpoints that led them to change their perspective. Some were pragmatic and concerned about the business model while others were motivated by hearing about children whose lives had been transformed through this process, or those that just needed to know what transition would look like and needed to hear examples from those that had successfully transitioned. Still others were motivated by research and academic studies highlighting the harms of institutionalisation on children. In each of those case studies, it was vital that those working with the RCI directors could understand their motivations and concerns to target their messaging more effectively. The Guidance Manual on Transitioning to Family Care for

[18] Better Care Network. 2021. A Case Study of the Process of Change: Transitioning Firefly Orphanage. Better Care Network and Kinnected; Better Care Network. 2021. A Case Study of the Process of Change: Bridges Safehouse. Better Care Network and Kinnected.

Children also supports this with a section on knowing your audience, what motivates them and what their concerns may be.[19]

"Identify RCIs that are really committed. If they are not clear, it is really challenging, and you spend a lot of resources and get no result." KII7

"We can help with reskilling the workforce, but really the desire has to come from the donors or the board itself." KII3

"We have one RCI that wants to join us for transition. We have been working with her for the last two years, just for the reintegration program, but when we did our work together, this will help a lot. She will talk to the donor with the new activities in her mind. She had her plan for after the transition and she brought this plan to talk with the donor." KII9

"Culture eats policy for breakfast and if you asked me what would be the biggest success, it is the move to get RCIs to recognise the importance of involving children in the decision-making process...It is that culture change that drives the transition." KII5

Another aspect of successful transition and closure was on changing the mindsets of community members, including CCWC members, but also the parents and the children. Several of those interviewed spoke about the important role that the CCWCs play in the placement of children and supporting gatekeeping. Several of those interviewed felt that changing the CCWC mindset is a key aspect of effective gatekeeping and preventing children from being placed unnecessarily into the RCIs in the first place.

"They [CCWC] are the gatekeeping mechanism. They are the ones that sign the enrolment to the RCIs. We need to work with these people to stop children being placed into RCIs." KII7

Others talked about the need to further sensitise parents on the harms of institutional care and the benefits of family-based care and how once a child has been in an RCI for a while, it can take time for them adjust to being back with family members or in the community. Still others felt that real change will come in Cambodia when parents and caregivers start to demand for

[19] Faith to Action Initiative. (2016). Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual.

their children to come home and have been changing their approach from focusing on working with RCIs to transition to focus more on building support and services within communities.

"The children are also used to receiving everything from the RCI and they change their lifestyle. They find it difficult to survive in the community. That is why we help care leavers." KII10

"The challenge is the family themselves. They still believe the RCI is the best place for children. Even if they can support the child, they still believe that the RCI is the best place for the child." KII4

"When we think children live in an RCI, it is better for them and when we integrate them into the family, we find a few ways to support them. This is what we learned from the experience we did. If the children live in the family, so we still find a new way, a new method to support them in the family." KII10

According to FHI360 which has created user friendly learning materials on how to develop a social behaviour change communication strategy,[20] one first needs to understand the gaps in knowledge to then design a communication strategy based on that analysis and create a strategy for each specific audience that an organisation is trying to influence. A content brief can help practitioners to identify the audience, what they want the audience (e.g. RCI directors or children and families) to do differently, what is keeping them from doing the desired behaviour, what motivates them and where they get information they trust.

Example Content Brief for Developing a Communication Strategy for Transition and Closure

Audience	What do we want them to do?	Why are they not doing it?	How do we motivate them?	Where do they get information, they trust
RCI Director	Transition their RCI to community-based services	Unclear of how to do it Fear of losing income	Appeal to greater good Showing them how others have successfully transitioned	CCWC, other NGOs, church if a religious organization

[20] FHI360 C-Modules: https://www.fhi360.org/resource/c-modules-learning-package-social-and-behavior-change-communication

			Supporting them to engage their donors	
Family members	Recognize the benefits of family-based care and support their children to be reintegrated	Misperception of benefits of RCIs Lack of services in their community	Awareness raising about the benefits of family-based care, harm in institutionalization Access to support within the community (income generating activities, support for fees for education etc.)	Marketplace Family members

Once that strategy has been designed and the messages have been created, the organisation needs to get feedback from the audience and community to see whether or not the messages are actually getting across and creating the change needed. The importance of reviewing the strategy was seen in the RAPID MERL review in 2018 of an SBCC campaign where the campaign did not appear to affect whether respondents believed that RCIs could result in harm generally, however it did affect whether or not respondents thought RCIs could be detrimental to the emotional development and physical wellbeing of children. Researchers recommended that future campaigns for community members provide more detail on why RCIs can be harmful for children.[21] A study on the attitudes towards residential care in Cambodia conducted by MoSVY and UNICEF reflect these views stating that 71 percent of commune council members and village chiefs thought that residential care was the best solution for children with no parents with 84 percent agreeing that a poor family should send their child to an RCI for education if they could not afford to pay school fees in the village. In this study, very few Village Chiefs had heard of community-based care options, but did feel if these options existed, they would be positive for children. While 61 percent of families agreed that family-based care was better for children, 85 percent also agreed that children in orphanages received a better education compared to those living in a village and that education and the perception of a better future superseded the advantages of home life.[22] While public campaigns have started to shift this mindset and build public support for the closure of RCIs, there is not current data to show that these mindsets have significantly changed yet. A baseline survey conducted in 2019 as the Keeping Families Together campaign relaunched,

[21] USAID. 2018. Rapid Feedback MERL & Cambodian Children's Trust Final Learning Check. Powerpoint Presentation.

[22] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. 2011. With the Best Intentions: Attitudes Towards Residential Care in Cambodia.

only 17 percent of community members understood the negative impact of institutionalization on children.

Community support

There was general agreement in the need for more services and support within communities, particularly focusing on poverty reduction and family supports, particularly for families facing multiple challenges like caring for children with disabilities or those with HIV/AIDs. While the provincial, district and commune level government often require support of civil society organisations, more work has been done to increase commune council budgets for social services, as highlighted in the Social Service Expenditure Guidelines in 2018.[23] However, one interviewee (KII12) noted that gaps still remain with the social assistance policy still limited for families with children under the age of two and while there is some reintegration support available for children being reintegrated from Government RCIs, this funding is not available for all reintegrating children.

"There has been too much time focused on a crisis response when we are missing out on a lot of prevention and early intervention. It is much cheaper with better outcomes. That might be the natural evolution." KII3

"If we want community-based care services, we need the potential services for children and their families, and this service needs to be sustainable. If the service is not sustainable, just one year or two year[s], our funds cut off so that the children that still need support, what should they do? We need to make clear what services to provide those children… and we need them [family] to have a strong income" KII12

"You need to address why those children were placed in the first instance and unless you address the root causes, you won't make any progress." KII3

"We increased our community foster care so if other clients can't go home, they go into foster care." KII6

"We need a bottom-up driver where the families are supported to care for the children themselves. Now they feel RCIs are better able to provide the support. They aren't doing this

[23] Better Care Network. (2020). Cambodia Country Care Profile. The Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation and the Better Care Network.

out of lack of love or ability to care for them. This is much more successful than driving it from the top down." KII3

Role of the Donors

While most of the work civil society in Cambodia has been doing is focused on targeting the RCI managers and directors, many organisations interviewed still find it challenging to engage the donors. This was the main barrier that many organisations found in helping RCIs to transition and the reason most cited as to why an RCI transition process failed to progress. Overseas donors are the main funders of residential care in Cambodia. According to the Study on Attitudes towards Residential Care almost 100 percent of funding for RCIs came from foreign funding. While some Cambodians had started RCIs, they relied on funding from overseas support.[24] Many RCIs use tourism to attract funders. Some collect funding from individual donors or churches with some relying on just one or two individuals for funding.

"We provide the reintegration, but each RCI is donor driven. They have to have the confidence to talk to the donors. The management has to be very confident and convincing, and most managers are cautious. 'If I change my direction, I am not confident that you will still be supporting my programmes. They are very dependent on the tourist and visitors and how these donors can understand and support." KII9

"I think it is a problem if we want all RCIs to 'change their plan', I use the word 'change their plan', they don't feel good because their donor says if they have RCIs, they provide the funds, if they don't provide RCIs, they don't provide the funds" KII12

"It is harder to raise funds with children in centres versus children in the community. It is a harder sell for most people and really the donors are blissfully unaware that the children aren't orphans." KII3

"They [RCI management] changed their commitment and their plan because their funders and their board of directors decided not to transform." KII7

"The biggest thing during the pandemic for the world, RCIs become more and more dependent. They used to rely on individual visitors coming to their centre, but now it is solely

[24] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. 2011. With the Best Intentions: Attitudes Towards Residential Care in Cambodia.

dependent on donors. We need to build the capacity of the management to speak with donors… not only in Cambodia, but in the world." KII9

There were many examples of work that had started with RCI directors and then stopped due to the lack of donor interest or support. In addition, the types of donors were also referenced with some explaining how much harder they found it to work with informally run RCIs and those that rely on sponsorship through multiple donors. Those that transitioned, including the organisations that transitioned themselves, all received backing from their donors or were able to find different donors to support. In several of the successful examples, the RCI directors were confident at fundraising themselves and also had a clear vision of what their new model of community care would look like. Fundamentally, transitioning requires a new business model. Faith to Action states that along with a plan and a vision, it is important to review financial and human resources and the resources needed to support and sustain the transition.[25] Donors are clear partners in the transition process which can be very challenging for civil society partners and local government given how protective and untransparent RCI directors can be about their donors and funding model.

Additionally, there were examples of RCIs that had to close immediately due to lack of funding or lack of donor support which created a crisis situation for the children in their care. Residential care often operates without long-term financial stability and some donors continue to be concerned that funding directed at families will not be spent on children.[26] Even those that had transitioned, recognised that fundraising for family and community-based care can be much harder, especially if donors were used to a sponsorship model allowing them to have an ongoing relationship with a specific child.

A study on the impact of COVID-19 on RCIs found that the control of fundraising and the ability to access alternative sources of funding to transition were the greatest determinants of whether a participant was willing and able to consider changes to their model of care including transition and closure. Eighty one percent of participants questioned in a study on the impact of COVID-19 on residential care noted that funding had been negatively impacted, including the ability to hold fundraising events, public speaking or through hosting volunteers or visitors in their facilities. The study cited anecdotal reports from Cambodia that COVID-19 restrictions

[25] Faith to Action Initiative. (2016). Transitioning Family Care for Children: A Guidance Manual.
[26] Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. 2011. With the Best Intentions: Attitudes Towards Residential Care in Cambodia.

had increased the openness of orphanage directors to explore family-based care and long-term reintegration.[27]

Given how influential the donors can be in whether or not transition and closure is successful, the Royal Government of Cambodia and civil society should consider incorporating a donor engagement strategy to form stronger partnerships with advocacy groups in donor countries and join similar initiatives to stop orphanage volunteering such as the Ministry of Tourism's child safe tourism campaign.

Considerations for RCI Staff

The biggest concerns that the key informants shared from the RCI staff and directors was in their funding model and the role of their staff. Some used funding to retrain the staff or reallocate them to community-based activities. Many of the NGOs helped to train the RCI staff in case management, reintegration techniques, foster care and how to manage data and fill out the relevant Government forms on each child. Some NGOs were involved in completely reskilling the staff to other professions of their choice. The majority of those interviewed felt that investing in the RCI staff made the transition process much easier and supported the transition to having skilled case workers and carers in the community.

This is also supported by the work of MoSVY to strengthen the social service workforce through a competency-based system. By the end of 2021 MoSVY and the National Institute of Social Affairs (NISA) will endorse Social Service Workforce training modules and training plans for 2022In focus group discussions with RCI staff as part of the FCF co-design process the need for support to help with family tracing and reunification and reintegration from NGOs was highlighted.[28]

"We have been able to understand the impacts of residential care on children and what the benefits would be to living with families. They [organisations supporting transition] have to be able to understand the facts, but then they have to be able to explain this to the RCIs. They also need to explain how their job would be secured." KII9

"Some RCIs are concerned about their jobs. The staff may lose their job, so we need to create other project work with the director" KII5

[27] Nhep, R. van Doore, K. (April 2021). *Impact of COVID-19 on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School.
[28] Focus group discussions with RCIs – Co-Design 2021 FDGs finding presentation.

"I know it is hard for our staff. We had to cut down our number of staff and they faced many challenges in their personal income… We help them find a job and do references and recommendations for them. Most of our caregivers have been placed in other organizations running shelters. Some have helped while running the foster care programme." KII6

"Some of the staff resigned, some were promoted to social worker and some, we asked them to be the foster parent of children." KII4

"Some of the staff were trained as social workers and still work with us today" KII3

Realistic timeframes

Almost all of those interviewed stressed the importance of taking the time to engage and build relationships with RCIs. Many of those that had transitioned themselves said that it had taken between 3-5 years, with the majority of time needed to get everyone on board and, create a vision of what their new model would look like, and then in working to reunify children with their families.

Most started with gatekeeping and creating individual care plans for each child, some with a traffic light system identifying those that could easily be reunified first, and then shifting in providing services based on their needs, whether that was temporary foster care, longer term foster care placement or semi-independent living. Some of the organisations stopped taking in new children but then waited for the children that could not be reintegrated in their centres to age out of care before closing their centre completely. While some organisations were concerned RCIs did not provide appropriate follow up for children that had been reunified, others, particularly those working with RCIs engaged in sponsorship felt the RCIs wanted to support the children far into adulthood.

"Most RCIs haven't done reunification plans properly. They want to take care of the children for the rest of their lives, like graduating from university and marriage." KII10

In retrospect, when asked what they would have done differently if they could do the process again, either in their own transition or in supporting others to transition, most interviewees said that they would take more time to develop a plan and shared vision before moving into reintegration. Given that children come from all provinces to the RCIs, some found challenges in ensuring that appropriate services and support were offered in their province of origin which highlights the need for a coordinated approach.

"It's a long journey, and that's what it takes." KII5

"It took several years for us as well, but once we came to a decision, once we had a decision it was 3-4 months to transition from the board approval and the communication to all staff and support office as well as donors." KII6

"Two years is not enough to work with RCIs on transition. Reintegration takes time (3-6 months). If we do it fast, we cannot raise our voice very high and DoSVY does not have much funding for transition… It is not just a commitment for 1-2 years. It should be at least 3 years." KII9

"When we partner with them, it takes 2-3 years. We provide capacity building for the director, but then if they change their position or a new staff member comes in, we have to support them." KII10

"It isn't a quick fix, and we don't turn that funding tap off completely as we would be left with a crisis to deal with." KII3

"I think things happened too quickly here. There was a big push, and it was happening. We didn't have all the help immediately. Some [RCIs] closed and didn't have the support." KII8

"Anyone who says they can do it quickly; they aren't doing it properly. This takes a bit of time. It is changing cultures." KII5

Emergency Closure

Those involved in emergency closure were very concerned about the pace of closure and the impact on the outcomes for children. They felt there was more work needed with RCIs to plan in advance, particularly for those RCIs that had failed inspection, but may not pose an immediate threat to children. Some of those that had worked on reintegrating children from RCIs following emergency closure felt that the Government more generally, and DoSVY specifically, needed to take more responsibility in making this transition happen smoothly. This is echoed in the Draft Guidelines for the Transition and Closure of RCIs[29] which highlight that emergency forced closures can be very traumatic for children as there is no time to prepare or consult with the child prior to emergency placement. It is also very challenging for both DoSVY and NGOs to find appropriate placements for the children. While forced emergency

[29]Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. Currently unpublished. Guidance for the Transition and Closure of Residential Care Institutions.

closures may sometimes be warranted if there is an immediate risk to the children in their care, more often non-emergency forced closures are more appropriate which allow for planning and ensure a better transition for the children in their care.

"Some run out of resources and need to close immediately and don't have reserve budget for reintegration." KII2

"It is very different from an RCI transition. RCI transition is a lot better because there is more time to prepare the strategy and better for the child." KII7

"For emergency closure, [there is] a committee and technical staff that go through the process, who is responsible for the children, specific programs to transition to, someone that can help. We work with local authority at the subnational level." KII10

Recommendations

According to a 2017 report by the Royal Government of Cambodia, "the rapid and uncontrolled increase in the number of institutionalised children in Cambodia, traditionally a country with community-based mechanisms for the alternative care of children, has long raised the concerns of the government and child protection workers."[30] As a result the Cambodian Government set an ambitious target of safely reintegrating 30 percent of children in residential care institutions (RCIs) into families.[31] By 2019, there has been a 43 percent reduction in the number of RCIs in Cambodia and a 59 percent reduction in the number of children in these facilities.[32]

In addition to this progress, COVID-19 caused global ramifications for anyone working in residential care settings. The study on the impact of COVID-19 stated that 90 percent of their respondents felt COVID-19 had catalysed reflection and created an opportunity to consider and implement changes. COVID-19 caused global ramifications for anyone working in residential care settings. While there are many devastating consequences of the pandemic, one of the benefits has been the opportunity to reflect on the use of RCIs, the consequences of emergency closure or reintegration and the reliance volunteers and visitors for fundraising. Those interviewed all had different views and experiences, there were common themes that emerged that can help to form future practice.[33]

It is clear that legislation and mandates from the national government are incredibly important in framing the need for transition and driving the ability to open, regulate and close residential care institutions. While the MoSVY has been quite clear through their national action plan about their ambition, greater clarity is needed at the district and provincial levels with clear roles and responsibilities for the CCWCs and local government to both oversee and support reintegration, particularly when there is no civil society partner able to play this role. These roles can be clarified further in the Guidelines on Transition and Closure of RCIs when endorsed by MoSVY. SOPs or interagency agreements between DoSVY, the civil society partner, and the RCI in helping to create a clear plan of action, set responsibilities and a shared vision to support in the transition process. In addition, DoSVY and the CCWCs need to have

[30] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2017). *Mapping of residential care facilities in the capital and 24 provinces of the Kingdom of Cambodia.* MoSVY, Kingdom of Cambodia.
[31] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2017). *Action Plan for Improving Child Care with a target of safely returning 30 percent of children to their families 2016-2018.* (extended to 2020)
[32] Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (2020). *Report on Results of the Implementation of the Action Plan for Improving Childcare.*
[33] Nhep, R. van Doore, K. (April 2021). *Impact of COVID-19 on Private Residential Care Institutions: Insights and Implications for Advocacy and Awareness Raising*. Better Care Network, Law Futures Centre, Griffith Laws School

appropriate funding to carry out the roles they have been allocated to support in transition and reintegration.

A number of those interviewed raised the challenge of trying to work with and influence unregistered RCIs. The Royal Government of Cambodia has created clear regulations and penalties for unlawfully running RCIs, however as the regulations have now been in place for some time, they now need to be more rigorously enforced to support compliance.

In addition to mandates, RCIs need support in learning from the many civil society organisations within Cambodia that have already successfully transitioned. Learning exchanges and sharing tools, policies and procedures can complement the legislative framework and help reduce the fear and uncertainty RCI directors and staff may feel as they start the transition process.

Transition and closure can take time and that having the time to plan the transition and develop a shared vision is beneficial to the staff, caregivers and more importantly to the children in their care. Government, donors, and civil society actors that are supporting the transition process need to allow for sufficient time and both human and financial resourced (at least 3 years of funding) to support this process. This includes funding for CCWCs and other sub-national actors to carry out their role effectively

Greater consideration and planning should be considered to support emergency closure to reduce the negative impact on children. While forced emergency closures may sometimes be warranted if there is an immediate risk to the children in their care, more often non-emergency forced closures are more appropriate which allow for planning and ensure a better transition for the children in their care. Those interviewed felt that DoSVY needs to play a greater role in supporting this process.

While advocacy and campaigning has helped to raise awareness within Cambodia, more data is needed to determine how much community member's perspectives have changed and which mechanisms are most helpful in facilitating this. It is clear from both the interviews and literature review that different messages are needed depending on the motivations and understanding of the RCI staff as well as community members. More work needs to be done to target the CCWCs and rural communities that may have had less exposure to the messaging. This can help to prevent placement in the first place, and support successful reunification.

Given how influential the donors can be in whether or not transition and closure is successful, the Royal Government of Cambodia and civil society should consider incorporating a donor engagement strategy to form stronger partnerships with advocacy groups in donor countries

and join similar initiatives to stop orphanage volunteering such as the Ministry of Tourism's child safe tourism campaign. Many donors have already successfully transitioned from using sponsorship of specific children as a fundraising model towards sponsoring children in a community. Lessons could be learned from how donors were encouraged to move from one form of giving to supporting communities.

Successful reintegration ultimately addresses the reasons that children were placed into RCIs in the first place. Greater investment in community-based services and outreach to at-risk families will provide much needed support to help keep children in families and reduce unnecessary separation.

ANNEXES

Annex I: Key Informant Interview Questions

1. How are you currently supporting RCIs to transition and/or closure?

2. How are the RCIs selected?
   - Did someone at the RCI approach you/your organisation, were they selected by DoSVY, or did you approach them?
   - At what stage was the RCI at when you approached them/they were assigned to you? (i.e. raising awareness/learning; planning and preparation phase, implementation phase)

3. How many RCIs have you been able to support?
   - Of these, how many have you supported through the conclusion of providing residential care services? Did they transition or close?
   - How many are still in process and what stage are they at?

4. Whom within the RCIs do you work with and how?
   - Looking back, are there other actors that you wish you had engaged but didn't?

5. What supports do you think RCI's need for transitioning and closure and what is currently provided?

6. Do you know where the RCIs that you are working with get their funding from?
   - If yes, where?

7. Do you know who founded the RCIs you are working for and why they were founded?

8. Do you think all RCIs can or should fully transition to providing other services? Why or why not?

9. How did your organisation approach the different steps in the transition process?

10. How long has the transition process with different RCIs taken?

11. In your experience, what factors helped RCIs to move forward in the transition process?
    - And what made it more difficult to move forward?

12. Have you ever had a situation where you became concerned about the welfare of children in the centre or concerned about the motives of the stakeholders in the RCI?
    - If yes, what did you do? If no, what do you think you would do?

13. How is the process similar or different for emergency closure?

14. Reflecting back on the process:
    - What advice would you give to others supporting RCIs to transition?
    - Think of an example that has been successful, what do you think lead to that success?
    - What has been the most challenging part of supporting RCIs to transition?
    - Is there additional advice, tools or guidance that you think would help you or other organizations assist in the transition process?
    - Is there anything that you have changed about the way you are working? Why?

FAMILY CARE FIRST | REACT

Ministries & Government Institutions

REACT Partners Network

Partners

Donors

Follow us

www.fcf-react.org

Family Care First - REACT